
SUS

Saúde Coletiva em Odontologia

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 SUS	3
02 SUS (parte 2)	6
03 SUS (parte 3)	9

01

SAÚDE COLETIVA EM ODONTOLOGIA
SUS

Aula ministrada pelo Dr. Prof Marcos Antônio Lima dos Santos, em 26 de agosto, na Universidade Cidade de São Paulo.

COMO SURTIU O SUS

Há décadas, o atendimento em serviços médicos eram bem diferente do atual.

Não existia o sistema público que temos hoje, ao qual toda a população tem acesso.

Os serviços de saúde tinham que ser comprados, ou seja quem tinha dinheiro era atendido por médicos particulares e quem não tinha era atendido em entidades filantrópicas, como as santas casas.



O INÍCIO DAS POLÍTICAS SANITÁRIAS DO BRASIL (1902)

No governo de Rodrigues Alves (1902-1906), tendo Oswaldo Cruz à frente, as iniciativas de saneamento e urbanização foram seguidas de ações específicas na saúde, sobretudo no combate a algumas doenças epidêmicas.

Foram tomadas medidas importantes, algumas drásticas, mas que representaram avanços no combate às epidemias, que se espalhavam facilmente pelas cidades.

Nesse contexto, nasceu um **Código Sanitário** que previa a desinfecção inclusive domiciliar, o arrasamento de edificações consideradas nocivas à saúde pública, a notificação permanente dos casos de febre amarela, varíola e peste bubônica, e a atuação da polícia sanitária.

As instituições de saúde se organizavam a partir do modelo campanhista, de inspiração bélica, para combater as epidemias.

Por isso, não é de se estranhar o teor extremamente autoritário das práticas de saúde.

Para desinfetar, percorriam ruas e visitavam casas, inclusive promovendo a queima de roupas e colchões.

Exigiam limpeza, reformas, interditavam prédios, removiam doentes.

Naturalmente, os alvos preferidos das visitas eram as áreas mais pobres e de maior densidade demográfica.

Também constava, nessa estratégia sanitária, a campanha de vacinação obrigatória que foi estopim de uma revolta popular, pelo caráter autoritário do processo.

Este movimento ficou conhecido como a **Revolta das Vacinas**, ocorrida no Rio de Janeiro, em 1904.

Na segunda fase do movimento sanitário de Oswaldo Cruz, entre **1910 e 1920**, o foco foi a zona rural.

As preocupações se resumiam no saneamento rural e no combate a três endemias rurais : *ancilostomíase*, *malária* e *mal de Chagas*.

Esse programa levou expedições de médicos sanitários pelo país e, proporcionou melhor conhecimento da situação de saúde no território nacional e da necessidade de se desenvolver uma política de Estado nessas áreas.

Apesar do fim conflituoso, Oswaldo Cruz conseguiu êxitos diante dos problemas epidemiológicos e colheu informações valiosas para seu sucessor, Carlos Chagas, o qual pôde estruturar uma campanha rotineira de educação e ação sanitária.

Em **1923**, foi realizada a **reforma sanitária brasileira**, com a criação do Departamento Nacional de Saúde, então ligado ao Ministério da Justiça.

CAPS (Caixa de Aposentadoria e Pensões): 1923 - 1933

Em **1923**, diante de revoltas populares, movimentos anarquistas e comunistas, o chefe de polícia, Eloy Chaves, propôs uma lei que regulamentava a formação de Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs).

No entanto, eram restritas a algumas organizações trabalhistas mais atuantes política e financeiramente, como os ferroviários e os marinheiros, ligados à produção exportadora.

Foi um marco na história da Previdência Social no Brasil, pois os funcionários poderiam ter direito à aposentadoria por invalidez ou por tempo de contribuição, bem como à pensão por morte e a assistência médica.

A administração e o financiamento ficaram a cargo dos trabalhadores e do patronato, sendo que 92% dos recursos dirigiam-se para aposentadoria, pensões ou

benefícios, e apenas 8% para a atenção à saúde.

A União permaneceu ausente desse modelo.

IAPS (Institutos de Aposentadoria e Pensões): 1933 - 1966

Nos **anos 30**, sob o governo de Getúlio Vargas, as CAPs foram transformadas nos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs).

As principais categorias de profissionais beneficiados foram: marinheiros, bancários, comerciários, industriários.

O Estado brasileiro passou a colaborar com 15% do total da receita, e o restante era custeado pelos trabalhadores e patrões.

Nesse período, ocorreu a *criação do Ministério da Educação e Saúde Pública (Mesp) e do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC)*.

Assim, esboçava-se o sistema de proteção social brasileiro, compreendendo a política de proteção ao trabalhador (com obrigatoriedade da carteira profissional, jornada de oito horas, direito a férias e a lei do salário mínimo) e, ainda, questões relativas à saúde.

Outro dado relevante foi a criação do **Conselho Nacional de Saúde**.

Na **década de quarenta**, em plena guerra mundial, o governo brasileiro, em convênio com o americano, **estruturou o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP)**.

Sua atuação norteou-se pela criação de postos permanentes, centros de saúde e postos rurais, em várias regiões, como os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, na contratação de sanitários em tempo integral e de uma equipe auxiliar com laboratoristas, escrivãos, médicos consultantes e visitantes.

Este órgão foi importante na introdução dos conceitos de desenvolvimento, de participação comunitária e de educação de grupos.

INPS (Instituto Nacional de Previdência Social): 1966 - 1977

O **golpe militar de 1964 e o Governo autoritário** que se instituiu criaram condições propícias para alterar o sistema de previdência social e de assistência médica

Em **1967** foi feita a reforma previdenciária, unificando cinco dos seus IAPs num único instituto – O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INPS);

O INPS passou a ser responsável pela assistência médica de todos os trabalhadores formais, que contribuíam com 8% dos seus salários, adicionados dos 8% da folha de salário das empresas.

Também estavam cobertos os trabalhadores autônomos ou empregadores que contribuíssem em dobro para o INPS (16%).

Essa ampliação na cobertura causou problemas para as instituições de assistência médica da previdência. Os estabelecimentos antigos do (IAPs) não comportavam essa nova clientela (do INPS).

Foi necessário aumentar as instalações, como também contratar uma rede de

estabelecimentos privados que, através de processos de compra e venda de serviços médicos passariam a integrar a rede de assistência do INPS.

O setor privado não tinha rede de atendimento suficientemente grande. Seria necessário ampliá-la para dar conta da nova demanda.

Boa parte da expansão da rede foi financiada com recursos públicos, ou seja, o governo militar financiou a criação de novos hospitais para a iniciativa privada com intuito posterior de compra de criação de serviços médicos (o que causou inúmeras fraudes, pois os hospitais cobravam do Governo serviços não praticados).

Começaram a ser realizadas grandes obras, como a ponte Rio - Niterói, a hidrelétrica de Itaipu, a rodovia Transamazônica.

Começou a ocorrer FRAUDES CONTRA O INPS, e as pessoas se aposentaram, e as obras faraônicas. Nisso o dinheiro acabou e o INPS faliu.

INAMPS (Instituto Nacional da Assistência Médica e Previdência Social): 1977 - 1993

Para tentar enfrentar o problema que se instalou, o governo cria o INAMPS.

Uma de suas ações foi criar um teto para pagamento de serviços médicos prestados pelo hospital.

Por exemplo: “ a partir de agora, para seu hospital, só pagaremos 30 radiografias de tórax por mês, 20 apendicectomias, 100 curativos ...”

O que aconteceu depois? Os hospitais começaram a diminuir a margem de lucro, em uma medicina cada vez mais cara.

ANOTAÇÕES

02

SAÚDE COLETIVA EM ODONTOLOGIA

SUS (parte 2)

O que eles fizeram? Quando batia a cota de radiografias, para não perder dinheiro, inventavam outros procedimentos que ainda não tinham batido a cota, para poder custear procedimentos que não seriam pagos, ou seja, criavam estratégias para continuar recebendo dinheiro e contribuíam para a situação de falência da previdência.

Mas por que o INAMPS acabou? Seguindo a mesma lógica do INPS, o setor privado continuou sendo privilegiado, nesse sentido o INAMPS patrocinou de forma substancial a expansão desse setor, através de empréstimos e recursos da população.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Ele já existia, assim como a vacinação, controle de endemias e o saneamento básico.

Após todos os problemas, eles necessitavam realizar uma mudança. A sociedade composta por médicos, estudantes e demais profissionais de saúde, resolveu propor uma reforma, a chamada **REFORMA SANITÁRIA**.

REFORMA SANITÁRIA

Iniciada na década de 1970, teve grande participação popular e de movimentos sindicais, com amplo apoio político.

PROPOSTAS:

PONTOS-CHAVE

- Universalizar o direito à saúde;
- Integrar as ações curativas e preventivas;
- Descentralização administrativa;
- Promover a participação e o controle social.

COMO AS PROPOSTAS FORAM COLOCADAS EM AÇÃO?

Plano CONASP e as Ações Integradas de Saúde: Estratégia importante rumo à universalização, integração e racionalização dos serviços públicos de saúde.

VIII Conferência Nacional de Saúde (1986): Saúde, direito de todos, dever do Estado. Tinha como objetivo final a criação do SUS.

Criação do Serviço Único e Descentralizado de Saúde - SUDS (1987): Retirar o poder centralizado do Governo Federal.

PAIS (PROGRAMA DE AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE): 1982

Em 1982 foi implementado o **Programa de Ações Integradas de Saúde (PAIS)**, que dava particular ênfase na atenção primária, sendo a rede ambulatorial pensada como a "porta de entrada" do sistema.

Visava a integração das instituições públicas da saúde mantidas pelas diferentes esferas de governo, em rede regionalizada e hierarquizada.

Propunha a criação de sistemas de referência e contra-referência e a atribuição de prioridade para a rede pública de serviços de saúde, com complementação pela rede privada, após sua plena utilização.

Prevvia a descentralização da administração dos recursos

Simplificação dos mecanismos de pagamento dos serviços prestados por terceiros e seu efetivo controle.

Racionalização do uso de procedimentos de custo elevado.

Estabelecimento de critérios racionais para todos os procedimentos.

Viabilizou a realização de convênios trilaterais entre o Ministério da Saúde, Ministério da Previdência e Assistência Social e Secretarias de Estado de Saúde, com o objetivo de racionalizar recursos utilizando capacidade pública ociosa.

Podemos reconhecer nas AIS os principais pontos programáticos que estarão presentes quando da criação do SUS.

VIII CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (1986)

A realização da **VIII Conferência Nacional de Saúde**, com intensa participação social, deu-se logo após o fim da ditadura militar iniciada em 1964, e consagrou uma concepção ampliada de saúde e o princípio da saúde como direito universal e como dever do Estado, atributos seriam plenamente incorporados na Constituição de 1988.

A VIII CNS foi o grande marco nas histórias das conferências de saúde no Brasil. Foi a primeira vez que a população participou das discussões da conferência.

Suas propostas foram contempladas tanto no texto da Constituição Federal/1988 como nas leis orgânicas da saúde, no 8.080/90 e no 8.142/90.

Participaram dessa conferência mais de 4 mil delegados, impulsionados pelo movimento da Reforma Sanitária, os quais propuseram a criação de uma ação institucional correspondente ao conceito ampliado de saúde, que envolve promoção, proteção e recuperação.

SISTEMA UNIFICADOS E DESCENTRALIZADOS DE SAÚDE (SUDS) - 1987

Nesse ano foram criados Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS) que tinham como principais diretrizes:

universalização e equidade no acesso aos serviços de saúde; integralidade dos cuidados assistenciais; descentralização das ações de saúde; implementação de distritos sanitários.

Trata-se de um momento marcante, pois, pela primeira vez, o Governo Federal começou a repassar recursos para os estados e municípios ampliarem suas redes de serviços, renunciando a municipalização que viria com o SUS.

As secretarias estaduais de saúde foram muito importantes neste movimento de descentralização e aproximação com os municípios, que recebiam recursos financeiros federais de acordo com uma programação de aproveitamento máximo de capacidade física instalada.

Podemos localizar no SUDS os antecedentes mais imediatos da criação do SUS.

CONSTITUIÇÃO CIDADÃ: 1988

Em 1988, foi aprovada a "Constituição Cidadã", que estabelece a saúde como "Direito de todos e dever do Estado" e apresenta, na sua Seção II, como pontos básicos:

As necessidades individuais e coletivas são consideradas de interesse público e o atendimento um dever do Estado;
A assistência médico-sanitária integral passa a ter caráter universal e destina-se a assegurar a todos o acesso aos serviços;

Estes serviços devem ser hierarquizados segundo parâmetros técnicos e a sua gestão deve ser descentralizada.

Estabelece, ainda, que o custeio do Sistema deverá ser essencialmente de recursos governamentais da União, estados e municípios, e as ações governamentais submetidas a órgãos colegiados oficiais, os Conselhos de Saúde, com representação paritária entre usuários e prestadores de serviços.

CRIAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (1990)

A Criação do Sistema Único de Saúde (SUS) se deu através da **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990**, que "dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes".

Primeira lei orgânica do SUS detalha os objetivos e atribuições; os princípios e diretrizes; a organização, direção e gestão, a competência e atribuições de cada nível (federal, estadual e municipal); a participação complementar do sistema privado; recursos humanos; financiamento e gestão financeira e planejamento e orçamento.

Logo em seguida, a **Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990**, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

O SUS é o Sistema Único de Saúde do Brasil.

É uma grande conquista da sociedade e foi criado para promover a justiça social e superar as desigualdades na assistência à saúde da população!

O SUS é uma política de Estado que amplia os direitos sociais e busca assegurar a cidadania.

Institui os Conselhos de Saúde e confere legitimidade aos organismos de representação de governos estaduais (CONASS - Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde) e municipais (CONASEMS - Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde).

Finalmente estava criado o arcabouço jurídico do **Sistema Único de Saúde**, mas novas lutas e aprimoramentos ainda seriam necessários, sendo um processo em construção.



ANOTAÇÕES

03

SAÚDE COLETIVA EM ODONTOLOGIA

SUS (parte 3)

PORQUE SISTEMA ÚNICO?

Porque ele segue a mesma doutrina e os mesmos princípios organizacionais em todo o território nacional, sob a responsabilidade das três esferas autônomas de governo federal, estadual e municipal.

Assim, o SUS não é um serviço ou uma instituição, mas um Sistema que significa um conjunto de unidades, de serviços e ações que interagem para um fim comum. Esses elementos integrantes do sistema referem-se ao mesmo tempo, às atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde.

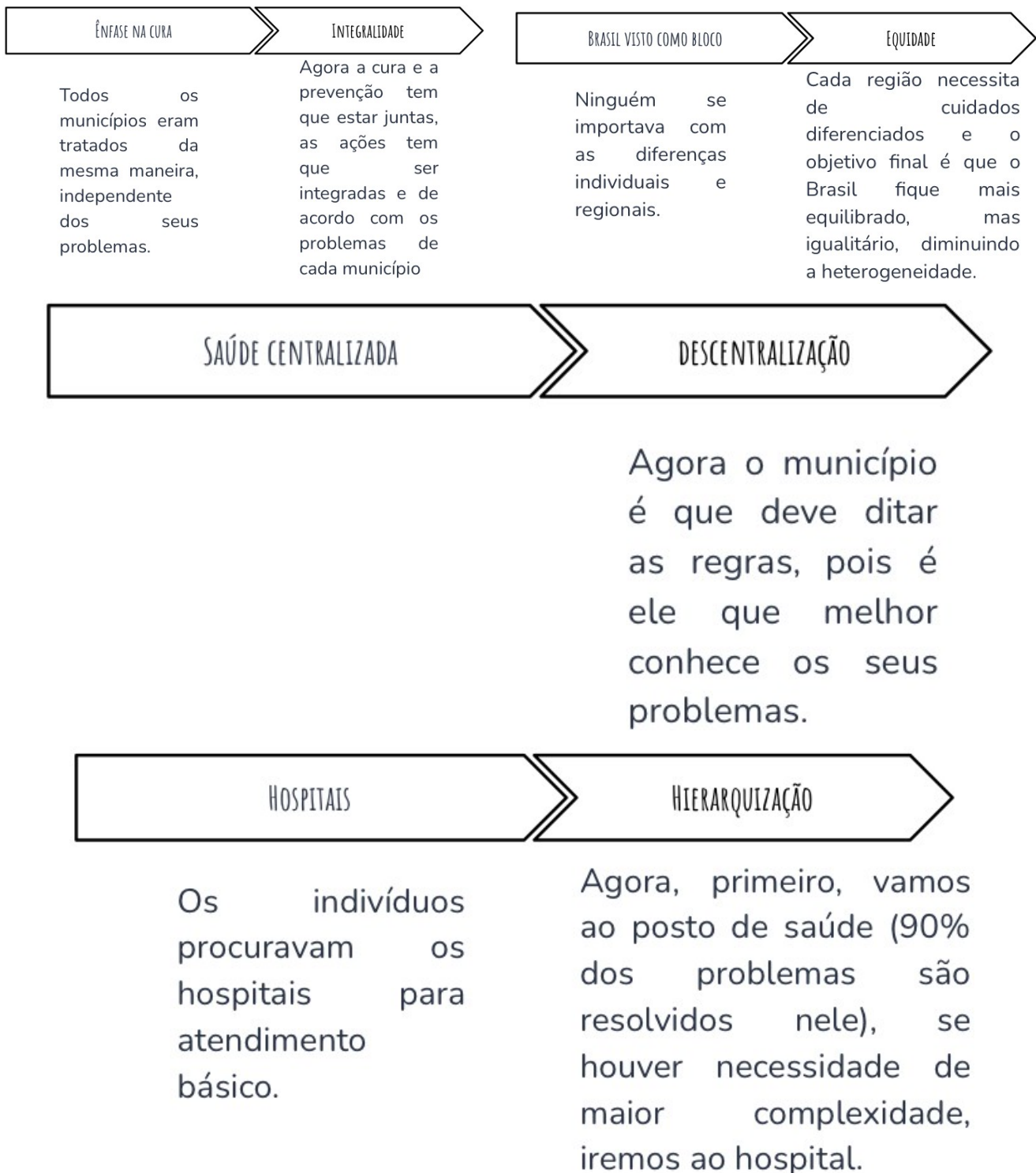
METAS DO MILÊNIO



PROBLEMAS VS. SOLUÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO -> princípios do SUS



Todos os cidadãos brasileiros tem direito a acesso à saúde pública.



POVO

CONTROLE SOCIAL

O povo não
palpitava, poucos
decidiam.

O povo tem direito
de participar, pois
ele é o maior
interessado, é ele
que “sofre”.

PRINCÍPIOS ÉTICOS E DOUTRINÁRIOS

UNIVERSALIDADE

Todo e qualquer cidadão tem direito de acesso à saúde.

INTEGRALIDADE

Direito à saúde em todos os níveis de complexidade (Ter um olhar do indivíduo como um todo).

IGUALDADE

Todos os cidadãos têm direito à saúde, sem qualquer discriminação ou pretexto.

EQUIDADE

Distribuição dos recursos para atender as necessidades de acordo com a complexidade dos problemas de saúde.

Cuidado para não confundir equidade com igualdade. Existe o princípio do SUS da igualdade, que inclusive está citado na Lei 8.080/90.

Ele afirma que deve existir igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, ou seja, não diferenciar por classe social, sexo, cor da pele...

**IGUALDADE****EQUIDADE**

PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS / OPERATIVOS

INTERSETORIALIDADE

Integração de vários setores para promover saúde.

CONTROLE

Participação da população na gestão do SUS através de Conselhos e Conferências de Saúde.

HIERARQUIZAÇÃO

Poder único em cada esfera do governo (federal, estadual e municipal).

REGIONALIZAÇÃO

Resolução dos problemas o mais próximo possível de onde eles acontecem (Municipalização da saúde).

DESCENTRALIZAÇÃO

O poder não fica apenas em uma única esfera do governo.

RESOLUTIVIDADE

Os problemas de saúde devem ser solucionados no âmbito do SUS.

COMPLEMENTARIDADE DO SETOR PRIVADO

Alguns serviços prestados são oferecidos em convênio com clínicas e laboratórios particulares.

DIREITO A INFORMAÇÃO

Todo cidadão deve ter acesso à informação sobre saúde.

PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA

Deve-se respeitar os desejos, as opiniões e as decisões dos usuários.

ONDE ENCONTRAMOS? Lei Orgânica do SUS (8080 - 8142)

LEI 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

“Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.”

LEI 8.142 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990

“Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área e dá outras providências”

CONSELHOS DE SAÚDE & CONFERÊNCIAS DE SAÚDE

CONSELHOS DE SAÚDE

São formados por representantes do Governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. Atuam no controle de execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

São PERMANENTES e DELIBERATIVOS. Indicam e nomeiam gestores dos serviços de saúde pertencentes ao SUS.

ATENÇÃO: Os conselhos se reúnem uma vez por mês ! 50% dos membros são os usuários!

CONFERÊNCIAS DE SAÚDE

São realizadas de quatro em quatro anos (podendo haver convocações extraordinárias pelos conselhos ou pelo poder executivo), com representantes dos vários segmentos sociais, com o objetivo de avaliar a situação da saúde

e propor as diretrizes para a formulação das políticas de saúde.

ATENÇÃO: Realizadas de quatro em quatro anos ! 50% dos membros são os usuários !

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SUS

Ênfase na prestação de serviços médicos individuais, de enfoque curativo, a partir da procura espontânea aos serviços.

PONTOS-CHAVE

Ações de Promoção

Ações de Proteção

Ações de Recuperação

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade.

1997 Criação do Disque Saúde.	1998 Sistema Nacional de Transplantes. Plano Estratégico de Mobilização Comunitária para o Combate à Dengue.	2002 Políticas Nacionais de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências.
2003 Criação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O programa "De Volta para Casa" contribui com o processo de reinserção social de pessoas com história de internação psiquiátrica	2004 Políticas Nacionais de Atenção Integral à Saúde da Mulher, de Humanização do SUS e de Saúde do Trabalhador	2004 Programa "Brasil Sorridente" - Um conjunto de ações para melhorar as condições de saúde bucal
2004 Programa "Farmácia Popular do Brasil"	2006 Política de Saúde da Pessoa Idosa.	2007 Política Nacional sobre o Álcool e veiculação de campanhas sobre o uso abusivo.
2009 Lançamento da Campanha Nacional de Prevenção à Influenza H1N1. Política Nacional de Saúde do Homem.	2010 Criação do primeiro cadastro nacional de pesquisas clínicas realizadas em seres humanos	

SUS soma mais vida

2 milhões de partos por ano são realizados pelo Sistema Único de Saúde

Aumenta a expectativa de vida

1988 – 69.7 anos

2011 – 73.1 anos

Mais transplantes são realizados

1997 – 3.765

2009 – 20.156

2011 – 24.600

Mais Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU

2003 – 10 milhões de pessoas

2011 – 111 milhões de pessoas

SUS multiplica atenção básica e saúde bucal

1994 – 300 equipes de saúde da família atendem 1,1 milhão de brasileiros

2009 – 30 mil equipes de saúde da família atendem 94,2 milhões de brasileiros

2011 – 32 mil equipes de saúde da família atendem 101,3 milhões de brasileiros

1994 – 29 mil agentes comunitários de saúde

2008 – 230 mil agentes comunitários de saúde em 5.354 municípios

2011 – 248 mil agentes comunitários de saúde em 5.393 municípios

2001 – 2.248 equipes de saúde bucal

2009 – 18 mil equipes de saúde bucal em 4.596 municípios

2011 – 21 mil equipes de saúde bucal em 4.854 municípios

SUS diminui mortalidade infantil

1990 – 53,7 por mil nascidos vivos

2011 – 21,17 por mil nascidos vivos

SUS distribui mais vacinas e medicamentos

1997 – 35.900 pacientes em terapia antirretroviral

2011 – 200 mil pacientes em terapia antirretroviral

1999 – nenhum medicamento genérico

2011 – 3.135 medicamentos genéricos registrados pela Anvisa

2004 – 27 farmácias populares

2.907 farmácias conveniadas

2011 – 553 farmácias populares

20.026 farmácias conveniadas

	Antes	Hoje
Número de pessoas beneficiadas	1988 – 30 milhões	190 milhões
Número de pessoas com plano de saúde	1988 – 23 milhões	46,6 milhões
Centros de especialidades odontológicas	2002 – 100 centros 60 municípios	867 centros 729 municípios
Medicamentos essenciais fornecidos	1988 – 40 medicamentos	400 medicamentos
Produção de medicamentos	1997 – 2,1 bilhões de unidades	7,8 bilhões de unidades
Produção de medicamentos antirretrovirais	1996 – 36 milhões de unidades	163 milhões de unidades
Capacidade de produção dos laboratórios públicos	1997 – 2,1 bilhões de unidades	7,8 bilhões de unidades
Centrais de transplantes estaduais	1996 – 5 Estados	Centrais de transplantes organizadas em 25 estados
Programa De Volta para Casa	2003 – 206 beneficiados	15.000 beneficiados

ANOTAÇÕES

Legislação do SUS

Odontologia em Saúde Coletiva

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 2

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Legislação do SUS	3
02 Legislação do SUS (parte 2)	7
03 Legislação do SUS (parte 3)	11

01

ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA

Legislação do SUS

Aula ministrada pelo Dr. Prof Marcos Antônio Lima dos Santos, em 02 de agosto, na Universidade Cidade de São Paulo.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (ARTIGOS 196 A 2000)

Art. 196: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197: São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198: As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.

Art. 199: A assistência à saúde é livre à iniciativa privada

Art. 200: Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei = Fiscalização e proteção de alguns seguimentos da sociedade relacionados a saúde;

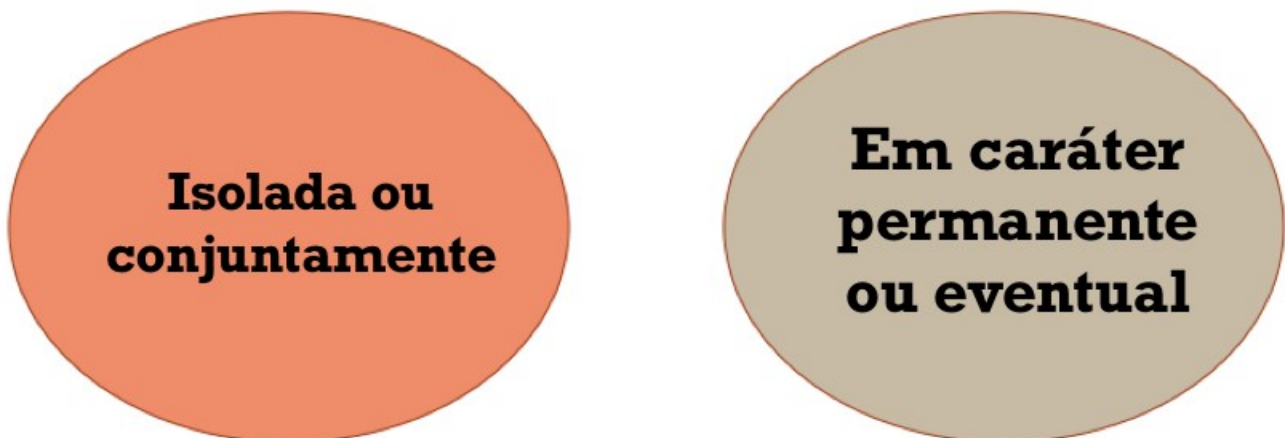
LEI ORGÂNICA DA SAÚDE - LEI Nº 8.080/1990

Existia a necessidade de uma legislação própria que explicasse como colocar essas orientações gerais na realidade do país.

Votada em 19 de setembro de 1990.

DISPOSIÇÕES GERAIS - ARTS. 1º A 3º

Art. 1º: Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde executados.



**Isolada ou
conjuntamente**

**Em caráter
permanente
ou eventual**

Art. 2º: A saúde é um DIREITO fundamental do ser humano → Devendo o ESTADO prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

RESPONSABILIDADE DO ESTADO:

Promoção, proteção e recuperação.

Perante as ações e serviços de saúde, necessidade de com o objetivo de reduzir risco de doenças e agravos, com o tipo de acesso para todos (universal e igualitário).

PARA GRAVAR O ART. 196 DA CF E O ART. 2º DAS LOS 8,080, BASTA FAZER AS SEGUINTE PERGUNTAS:

A saúde é um direito de quem? *De todos!*

Dever de quem? *Do estado!*

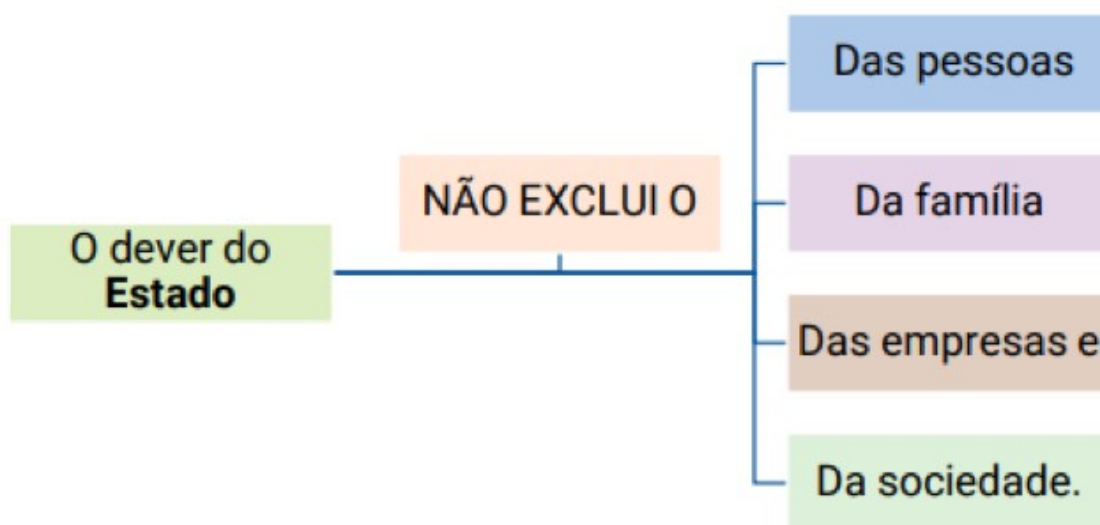
Para que ela seja implementada, o que deve ser feito? *Uma política econômica e social.*

Com que objetivos? *Reduzir o risco de doenças e de urros agravos!*

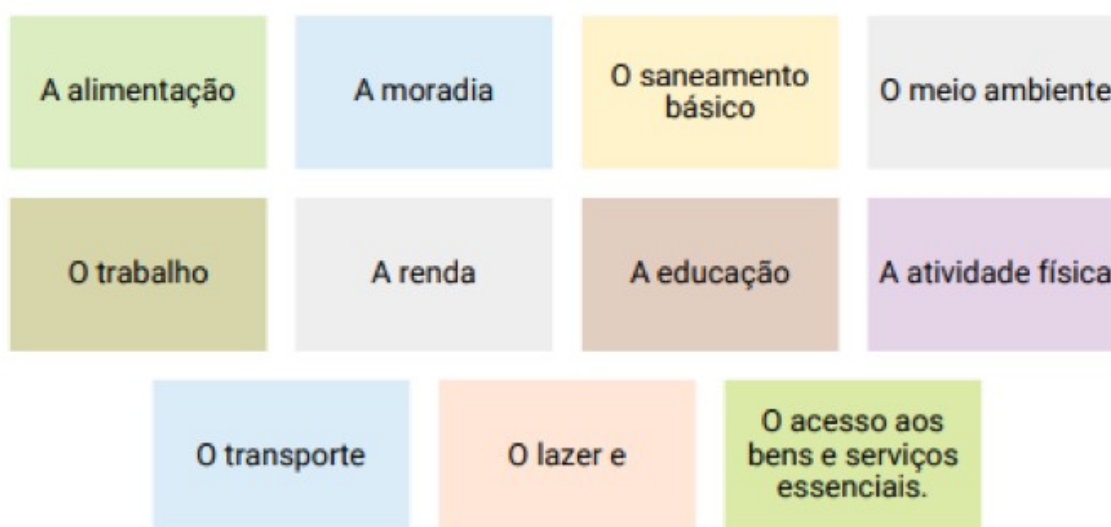
Com que tipo de acesso? *Universal e igualitário!*

Para que tipo de ações? *Promoção, proteção e recuperação.*

O artigo 2 traz a corresponsabilidade de todos, mas lembre-se de que o dever de prover as ações e serviços de saúde é do estado.



Art. 3º: Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros:



Dizem respeito também à saúde as ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ART. 4º

Art. 4º: O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas

Da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

PONTOS-CHAVE

Federais;
Estaduais;
Municipais.

Este artigo traz o conceito do SUS.

O sistema de saúde é o conjunto de ações prestadas por todas as esferas de governo, incluindo a administração direta e indireta.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA

A Administração Pública direta é o conjunto de órgãos ligados diretamente ao Poder Executivo, em nível federal, estadual e municipal.

Esses órgãos são subordinados ao chefe do poder a que pertencem, isto é, existe uma hierarquia entre eles.

Os órgãos da administração direta são pessoas jurídicas de direito público e têm autonomia.

Nesse caso, os serviços públicos são prestados por seus próprios meios, ou seja, sem a criação de nova personalidade jurídica.

Conjunto de órgãos que prestam serviços públicos e estão vinculados a uma entidade da administração direta, mas possuem personalidade jurídica própria, isto é, têm CNPJ próprio.

Resultado da complexificação das funções estatais e da necessidade de fornecer flexibilidade na prestação dos serviços públicos.

Essa descentralização tem como objetivo aumentar a eficiência e a eficácia das atividades administrativas e serviços de interesse coletivo.

No caso dos órgãos da administração indireta, embora não haja um controle hierárquico, as entidades estão sujeitas ao controle e fiscalização do Estado.

AUTARQUIAS

Instituídas por lei, têm autonomia administrativa e financeira, mas estão sujeitas ao controle do Estado. São entidades de direito público e sua atividade fim é de interesse público.

FUNDAÇÕES PÚBLICAS

São criadas por lei e podem ser entidade de direito público ou privado. Sua atividade fim deve ser de interesse público e essas organizações não podem ter fins lucrativos.

EMPRESAS PÚBLICAS

São pessoas jurídicas de direito privado, criadas por autorização legal e administradas pelo poder público. O capital das empresas públicas é exclusivamente público. Essas empresas prestam serviço de interesse coletivo e exercem atividades econômicas.

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

Pessoas jurídicas de direito privado, criadas sob a forma de sociedade anônima e compostas por capital público e privado. A maior parte das ações dessas empresas são do Estado. Assim como as empresas públicas, prestam serviços públicos e exercem atividades econômicas.

ART. 4

Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

Participação do setor privado no SUS ocorre na forma de contratação de serviços.

PANDEMIA

O senado aprovou o uso de leitos de UTI particulares por pacientes do SUS.

Farmácia popular

OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES - ARTS. 5 E 6º

Art. 5º: São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:

1. Identificação e divulgação → Dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
2. A formulação de política de saúde → Destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no 1º do art 2º desta lei.

ANOTAÇÕES

02

ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA

Legislação do SUS (parte 2)

3. A assistência às pessoas → Por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

A LOS 8.080/90 TRAZ OS 3 OBJETIVOS DO SUS:

Objetivo 1: através desta lei, o conceito de saúde é ampliado e passa a ser um conjunto de fatores determinantes e condicionantes. *Ou seja, identificar e divulgar estes fatores determinantes!*

Objetivo 2: Formular uma política econômica e social.

Objetivo 3: o art. 196 da CF/88 e o art. 2º desta lei dizem que as ações e serviços de saúde devem ser de promoção, proteção e recuperação. Logo, o objetivo é assistir às pessoas por meio de ações de promoção, proteção e recuperação. Lembrando ainda que deve existir o somatório das ações preventivas e curativas, com prioridade para as ações preventivas.

ART. 6º

Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I – a execução de ações:

a) de vigilância sanitária; b) de vigilância epidemiológica; c) de saúde do trabalhador; d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

II – a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;

III – a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;

IV – a vigilância nutricional e a orientação alimentar;

V – a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho;

VI – a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção;

VII – o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde;

VIII – a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano;

IX – a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

X – o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico;

XI – a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.

1. Entende-se por vigilância sanitária como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

A. O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo;

B. O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

2. Finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

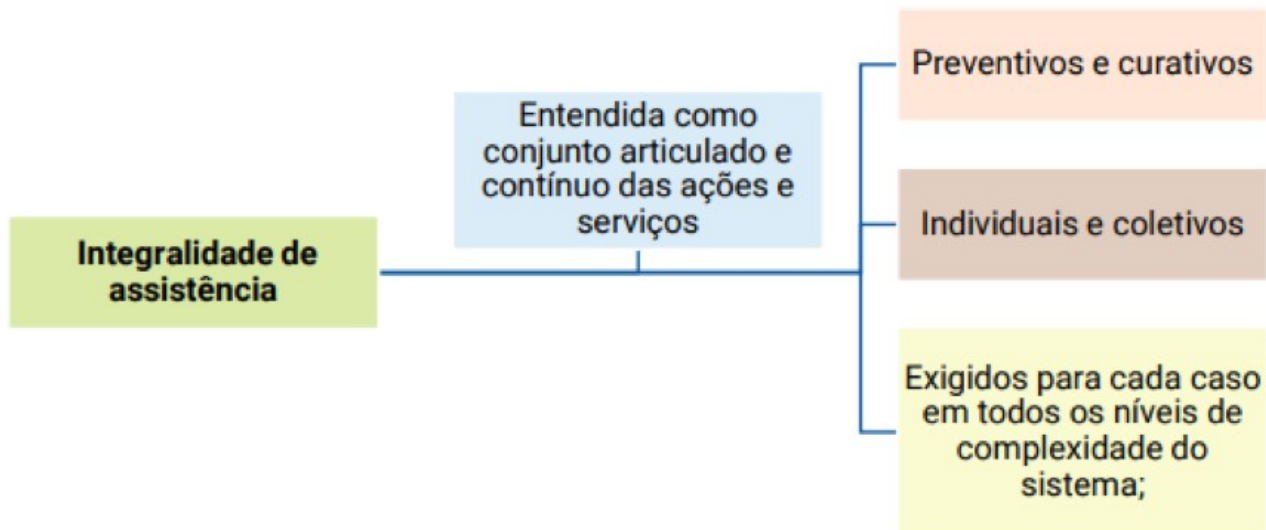


3. Entende-se por saúde do trabalhador, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo:

- A. Assistência ao trabalhador vítima de acidentes e trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
- B. Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
- C. Participação na normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador.
- D. Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
- E. Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional.
- F. Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas.
- G. Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais.
- H. A garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

ART. 7º

1. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
2. ↓



3. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

4. Igualdade da assistência à saúde.



5. Direito à informações, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.

6. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

7. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

8. Participação da comunidade.

9. Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

10. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

11. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos.

Da união; Dos estados; Do Distrito Federal; Dos municípios;

Na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

12. Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

13. Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

14. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei n. 12.845, de 1o de agosto de 2013.

Os **PRINCÍPIOS** são valores que orientam os nossos pensamentos e ações.

DOCTRINÁRIOS - Universalidade, integralidade e equidade (a equidade não consta entre os princípios do SUS: o princípio central nesse marco legal é a IGUALDADE).

ORGANIZATIVO: Todos os demais que constam no art. 7o.

Integralidade é diferente de universalidade:

PONTOS-CHAVE

INTEGRALIDADE – O princípio da integralidade determina que o usuário da saúde deve ser visto como ser único, que está inserido em um meio coletivo.

UNIVERSALIDADE - é a garantia de que todos tenham acesso aos serviços de saúde.

A equidade é um princípio do SUS que não está expresso na lei. A equidade adapta a regra da igualdade para um determinado caso específico, com a finalidade de torná-la mais justa.

ANOTAÇÕES

03

ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA

Legislação do SUS (parte 3)

DA ORGANIZAÇÃO, DA DIREÇÃO E DA GESTÃO - ARTS. 8º A 14-B

Art. 8º: As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados:

De forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente.

Art. 9º: A direção do SUS é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:



Art. 10º: Os municípios poderão constituir consórcios.

1. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.
2. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular:

PONTOS-CHAVE

- Recursos
- Técnicas
- Práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde de saúde que lhes correspondam

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

Consórcio significa, do ponto de vista jurídico e etimológico, a união ou associação de dois ou mais de dois entes da mesma natureza.

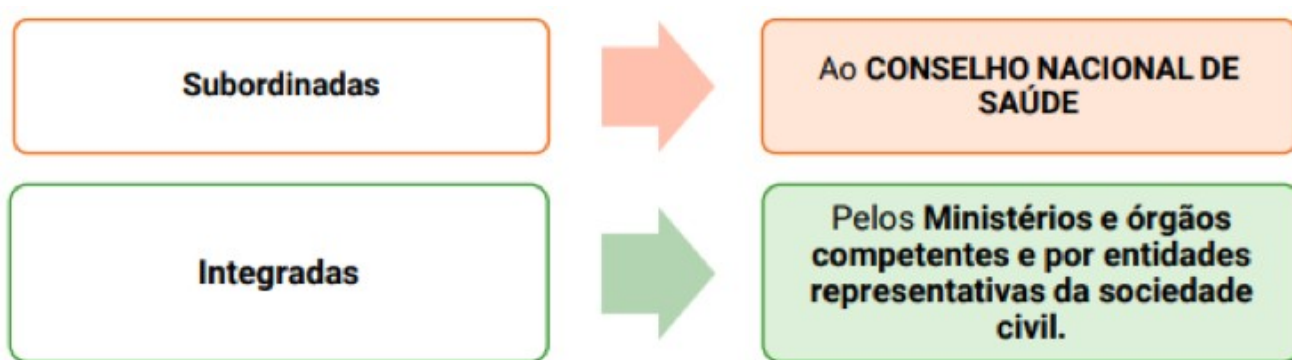
Ele constitui um instrumento, um meio, uma forma, para a resolução de problemas ou para alcançar objetivos comuns.

Ao expressar um acordo firmado entre municípios, ele possibilita aos prefeitos municipais assegurar ações e serviços mediante a utilização dos recursos materiais e humanos disponíveis.

A união desses recursos produzirá os resultados desejados, o que não ocorreria se os municípios atuassem isoladamente.

O art. 11 foi VETADO.

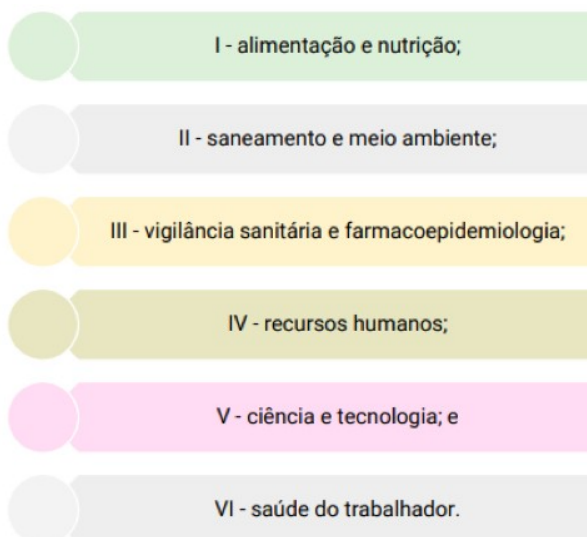
Art. 12: Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional.



As **COMISSÕES INTERSETORIAIS** terão finalidade de:

Articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 13: A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades: ↓



Art. 14: Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre, OS SERVIÇOS DE SAÚDE E ➔ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PROFISSIONAL E SUPERIOR.

Cada uma dessas comissões terá por finalidade:

Propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde (SUS), na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições.

Art. 14-A: As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como Foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo:

I - Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS,
- Em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde,
- Aprovados pelos conselhos de saúde;

II - Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante

- À sua governança institucional e
- À integração das ações e serviços dos entes federados;

III - fixar diretrizes sobre

- As regiões de saúde,
- Distrito sanitário,
- Integração de territórios, referência e contrarreferência e
- Demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados.

Art. 14-B:



São reconhecidos como ENTIDADES REPRESENTATIVAS dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidades públicas e de relevante função social, na forma do regulamento.

O Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e o Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) receberão:

Recursos do orçamento geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde.

Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) são reconhecidos como:

Entidades que representam os entes municipais, no âmbito estadual.

Para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao Conasems, na forma que dispuserem seus estatutos.

ANOTAÇÕES

Determinantes Sociais de Saúde

Odontologia em Saúde Coletiva

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 3

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Determinantes Sociais de Saúde – Processo Saúde-Doença	3
02 Determinantes Sociais de Saúde – Processo Saúde-Doença (parte 2)	6
03 Determinantes Sociais de Saúde – Processo Saúde-Doença (parte 3)	9
04 Determinantes Sociais de Saúde – Processo Saúde-Doença (parte 4)	13

01

ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA

Determinantes Sociais de Saúde – Processo Saúde-Doença

Aula ministrada pelo Prof. Dr Marcos Antônio Lima, em 19 de agosto de 2022, na Universidade Cidade de São Paulo.

A doença não pode ser definida por alterações fisiopatológicas, quem irá definir a doença é a dor, sofrimento, e os sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que adocece.

CONDIÇÃO DE SAÚDE = subindividualidade + individual + coletivo.

SUBINDIVIDUAL

PONTOS-CHAVE

- Nível biológico e orgânico;
- Nível fisiológico ou fisiopatológico.

Na subindividualidade o processo saúde-adoecimento (PSa) seria definido pelo equilíbrio dinâmico entre **ANORMALIDADE E NORMALIDADE** e **FUNCIONALIDADE E DISFUNÇÕES**.

Quando a balança tende ir para a ANORMAIDADE, as disfunções ocorrem em **EFERMIDADE** (a pessoa reconhece) e a **DOENÇA** (nos CD's reconhecemos).

EFERMIDADE = condição percebida pela pessoa ou paciente, caracterizando-a como queda de ânimo, algum sintoma físico, ou mesmo como dor.

DOENÇA = condição detectada pelo profissional de saúde, com quadro clínico definido e enquadrada como uma entidade ou classificação médica/odontológica.

INDIVIDUAL

Disfunções e anormalidades ocorrem em indivíduos que são seres biológicos e sociais ao mesmo tempo.

As alterações no processo saúde-adoecimento resultam não só dos aspectos biológicos, mas também das condições gerais da existência dos indivíduos, grupos e classes sociais, ou seja, teriam dimensões individuais e coletivas.

CONDIÇÃO DE SAÚDE = varia entre um extremo de mais perfeito bem-estar até o extremo da morte, com uma série de processos e eventos intermediários entre os dois.

COLETIVO

É encarado não como a simples soma das condições orgânicas e sociais de cada indivíduo isoladamente, mas sim como a expressão de um processo social mais amplo, que resulta de complexos fatores e relações, representados por determinantes do fenômeno nos vários níveis de análise.

Temos que lembrar que a saúde é silenciosa, geralmente não a percebemos, é só inidentificável quando adoecemos.

Não existe um limite preciso entre a saúde e a doença.

Entre a normalidade e a patologia, na qual “os mesmos fatores que permitem ao homem viver podem causar doença, se agem com determinada intensidade, se pesam em excesso ou faltam, se agem sem controle”. Essa relação é demarcada pela forma de vida dos seres humanos, pelos determinantes biológicos, psicológicos e sociais.

O processo saúde-doença-adoecimento ocorrer de maneira desigual entre os indivíduos, as classes e os povos, recebendo influência direta do local que os seres ocupam na sociedade.

Para a saúde, é necessário partir da dimensão do ser, pois é nele que ocorre as definições do normal ou patológico. O considerado normal em um indivíduo pode não ser em outro.

Temos que considerar que analisar o conceito de que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e grupos da população estão relacionados com sua situação de saúde.

Para a **Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS)**, estabelecida em 2006, os DSS são:

“Os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população”.

As relações entre determinantes sociais e saúde consistem em estabelecer uma hierarquia de determinações entre fatores mais distais, sociais, econômicos e políticos e mais proximais relacionados diretamente ao modo de vida, sendo distintos os fatores que afetam a situação de saúde de grupos e de pessoas.

Segundo relatório da CNDSS (2008), a análise da situação de saúde compreende seis itens:

1. Situação e tendências da evolução demográfica, social e econômica do país;
2. A estratificação socioeconômica e a saúde;
3. Condições de vida, ambiente e trabalho;
4. Redes sociais, comunitárias e saúde;
5. Comportamentos, estilos de vida e saúde;
6. Saúde materno-infantil e saúde indígena.

SITUAÇÃO E TENDÊNCIAS DA EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA, SOCIAL E ECONÔMICA DO PAÍS

Traça um panorama geral de referência para a análise da situação de saúde, descrevendo a evolução destes macrodeterminantes, particularmente nas últimas quatro décadas.

ESTRATIFICAÇÃO SOCIOECONÔMICA E A SAÚDE

Apresenta a situação atual e tendências da situação de saúde no país, destacando as desigualdades de saúde segundo variáveis de estratificação socioeconômica.

CONDIÇÕES DE VIDA, AMBIENTE E TRABALHO

Apresenta as relações entre situação de saúde e condições de vida, ambiente e trabalho, com ênfase nas relações entre saneamento, alimentação, habitação, ambiente de trabalho, poluição, acesso à informação e serviços de saúde e seu impacto nas condições de saúde dos diversos grupos da população.

REDES SOCIAIS, COMUNITÁRIAS E SAÚDE

Inclui evidências sobre a organização comunitária e redes de solidariedade e apoio para a melhoria da situação de saúde, destacando particularmente o grau de desenvolvimento dessas redes nos grupos sociais mais desfavorecidos.

COMPORTAMENTO, ESTILO DE VIDA E SAÚDE

Inclui evidências existentes no Brasil sobre condutas de risco como hábito de fumar, alcoolismo, sedentarismo, dieta inadequada, entre outros, segundo os diferentes estratos socioeconômicos da população.

SAÚDE MATERNO-INFANTIL E SAÚDE INDÍGENA

Por sua importância social e por apresentarem necessidades específicas de políticas públicas, são dedicadas seções especiais sobre saúde materno-infantil e saúde indígena.

MODELO PROPOSTO PARA ESTUDAR DETERMINANTES E TRAMA: um adotado pela CNDSS é o modelo de Dahlgren e Whitehead que inclui os DSS dispostos em diferentes camadas, desde uma camada mais próxima dos

determinantes individuais até uma camada distal, onde se situam os macrodeterminantes.

A análise dos determinantes sociais de saúde nos permite intervenções no sentido de ampliar políticas públicas que possam reduzir as iniquidades, desigualdades consideradas injustas, e avançar para políticas de saúde com mais equidade.

Para além do conceito epidemiológico de determinantes sociais de saúde como fatores de risco, é necessário ainda, compreender a determinação social da saúde como um conceito mais ampliado e politicamente construído.

O PAPEL DA EQUIPE NA ATUAÇÃO NO PROCESSO SAÚDE DOENÇA

A equipe da Estratégia de Saúde da Família precisa ter consciente seu papel de educador em saúde e conjuntamente saber o resultado que quer atingir em cada situação.

É preciso contribuir com a autonomia dos sujeitos no sentido de que cada um seja protagonista de sua produção de saúde.

É recomendável o treinamento da percepção sensorial: onde focar a atenção e como modificar e ampliar os filtros para poder observar coisas que não eram percebidas anteriormente.

FILTRO = experiências vividas por nós, imagens internas, Sons e sensações que nos dão um significado especial e que fica arquivado em nosso cérebro e que nos vem à mente nas mais diversas situações.

Ex: crenças religiosas. Nosso aprendizado na área específica funcionam como filtros, levando-nos a agir de certa uma maneira e a prestar mais atenção a algumas coisas do que a outras.

Ao prestar a assistência ao indivíduo, à família ou à comunidade deve se considerar quem é ou quem são os usuários, como se apresentam na situação de necessidade de saúde, seus direitos, deveres, valores.

ANOTAÇÕES

02

ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA

Determinantes Sociais de Saúde – Processo Saúde-Doença (parte 2)

O ser humano é complexo e não há como abranger sua totalidade por uma única definição. Mesmo que se considere a pessoa um ser biopsicossocial e espiritual, não se consegue expressar toda sua individualidade e singularidade.

Não podemos nos esquecer de que o ambiente é o local onde a pessoa se encontra com as coisas ao seu redor e que exercem nela influências, afetando-a de várias maneiras.

PONTOS-CHAVE

- Conflitos entre si;
- Problemas que atingirão sua saúde mental;
- Provavelmente acarretará doenças;

O **processo saúde-doença** é um dos pontos centrais para os profissionais da saúde que buscam promover a saúde, cuidando para que as pessoas possam ter uma boa qualidade de vida, mesmo quando as limitações se estabelecem.

Quando planejamos ações que vão mudar a vida dos nossos pacientes, devemos sempre fazer os seguintes questionamentos:

1. Para quem é? 2. Para quem? 3. Como? 4. Quando? 5. Onde será realizada a ação?

Isso faz toda a diferença quando organizamos nossos serviços voltados às necessidades das pessoas que vivem no território onde atuamos e temos a produção de saúde e de cuidado como foco de nosso trabalho.

É necessário compreender as condições impostas como passíveis de interferência e atentar para não culpar os indivíduos quando tais condições são insalubres e interferem em seu estilo de vida.

Trabalhar com as condições de vida impostas requer um trabalho interdisciplinar e intersetorial.

A área da saúde sozinha não consegue assegurar qualidade de vida e, conseqüentemente, de saúde.

É na esfera da ética que compreenderemos a necessidade do empenho de parte significativa da sociedade para assegurar a dignidade da vida humana.

Ao compreender que o corpo humano não é um produto isolado, pois existe em relação com outros seres em um dado contexto social, cultural e político, entendem que, para cuidar da pessoa, faz-se necessário considerar algumas questões pertinentes ao vínculo saúde-doença-adoecimento-sociedade: **as condições de vida impostas e os estilos de vida escolhidos pelos próprios indivíduos.**

A primeira situação diz respeito à esfera pública, na qual nem sempre o indivíduo consegue interferir sem a participação do Poder Público; a segunda localiza-se no mundo privado, onde o indivíduo define a melhor forma de se utilizar da própria vida.

Cabe aos profissionais da saúde rever sua prática, buscando entender que não basta trabalhar com as doenças.

É necessário compreender o indivíduo no todo como alguém que vive a experiência da necessidade, do adoecimento, carregada de valores e significados subjetivos, únicos, capazes de interferir na qualidade do cuidado prestado.

Assim, resta-nos, como profissionais da saúde, enfrentar o desafio de construir estratégias para conceber a saúde no âmbito da atenção básica de forma mais solidária e menos punitiva na convivência com os estilos de vida individuais.

ATENÇÃO À SAÚDE

É uma atenção ou assistência?

Em uma visão ampliada do PSa, as práticas de saúde devem ir além da assistência à saúde de indivíduos, ocupando-se também da atenção à saúde.

Assistência = conjunto de procedimentos clínico-cirúrgicos dirigidos a indivíduos, estejam eles doentes ou não.

Atenção = conjunto de atividades intra e extra-setor saúde (intersetorialidade) que, incluindo também a assistência individual, não se esgota nela, atingindo grupos populacionais com o objetivo de manter a condição de saúde, requerendo ações concomitantes sobre todos os determinantes do PsA.

Partindo dessa perspectiva ampliada de saúde, podemos entender a **atenção à saúde** como sendo o campo de competência do profissional de saúde dentro de um PSa, compreendido como complexo e multideterminado, reconhecendo-se as limitações importantes do setor de saúde nesse processo.

A atenção à saúde seria o objeto de atuação dos serviços de saúde, tanto os de Saúde Pública, quanto os de Saúde Suplementar.

AÇÕES DA ATENÇÃO À SAÚDE

De modo geral, deve-se promover ações individuais e ações coletivas dentro de um modelo ampliado de atenção à saúde.

As ações individuais, dentro desse conceito ampliado, reconhecem os indivíduos como sujeitos, portadores de direitos e responsabilidades – não mais como objetos de ações coletivas, que

antes não reconheciam as singularidades das pessoas e comunidades.

Essas ações podem ser preventivas ou terapêuticas, como por exemplo: aplicação de vacina, restauração dentária, sutura, entre diversas outras.

As ações coletivas devem impactar grupos ou organizações, pressupondo algum tipo de interesse específico compartilhado, ou ainda a interação entre os participantes.

Tanto as ações individuais quanto as coletivas devem buscar a integralidade, em 3 dimensões:

1. **Vertical:** que busca atender a todas as necessidades de saúde do indivíduo (desde a promoção da saúde até a reabilitação), entendido em toda a sua complexidade biopsicosocial e espiritual.
2. **Horizontal:** que busca a integração de ações e serviços de atenção à saúde ao longo do tempo, para garantir a condição de saúde das pessoas.
3. **Intersetorial:** que reconhece os setores extra-saúde (educação, segurança) como fundamentais para a promoção da saúde.

PROGRAMAS DE ATENÇÃO À SAÚDE

Os programas de atenção à saúde definem ações articuladas individuais e coletivas, recursos, tecnologias e estratégias para o enfrentamento das necessidades de saúde das pessoas e comunidades.

Podem ser voltados a determinadas condições de saúde, ou a determinados grupos populacionais, ao longo do tempo.

PROMOÇÃO DA SAÚDE E NÍVEIS DE PREVENÇÃO

A promoção da saúde foi nominada, pela primeira vez, pelo sanitarista Henry Sigerist, no início do século XX.

Ele elaborou as quatro funções da Medicina: promoção da saúde, prevenção das doenças, tratamentos dos doentes e reabilitação.

Segundo a sua concepção, a promoção da saúde envolveria ações de educação em saúde e ações estruturais do Estado para melhorar as condições de vida da população.

Leavell & Clark, em 1965, propuseram o modelo da história natural da doença, composto por três níveis de prevenção : **prevenção primária, secundária e terciária**.

Nesse modelo, a promoção da saúde se limitava e compunha um nível de atenção da Medicina Preventiva (prevenção primária), constituindo ações destinadas ao desenvolvimento da saúde e bem-estar geral no período de pré-patogênese.

HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA

Quando falamos de *História Natural da Doença*, estamos nos referindo ao desenvolvimento de determinada patologia ao longo do tempo, desde a exposição do paciente até seu encerramento, sem quaisquer intervenções humanas, ou seja, a doença seguindo o seu curso natural.

Assim, de forma resumida, as doenças passam por três períodos específicos.

PERÍODO DE PRÉ-PATOGÊNESE

A doença ainda não está instalada, existindo apenas interações entre agente infeccioso, hospedeiro (ser humano) e o ambiente. Nesta etapa o indivíduo está apenas exposto e suscetível a adquirir determinada patologia.

PERÍODO DE PATOGÊNESE OU FASE CLÍNICA

Este é o período em que a patologia está em desenvolvimento no organismo do hospedeiro. Ocorrem mudanças patológicas, a doença passa do período de incubação para período sintomático e infeccioso, se for o caso.

PERÍODO DE INCAPACIDADE RESIDUAL

Por fim, com a doença seguindo seu curso natural, sem intervenções, o indivíduo pode se recuperar, se tornar portador, vir a óbito ou desenvolver deficiências.

A PROMOÇÃO DA SAÚDE E OS NÍVEIS DE PREVENÇÃO SEGUNDO LEAVELL & CLARK (1965)

PRIMÁRIA

A promoção da saúde aparece como prevenção primária, confundindo-se com a prevenção referente à proteção específica.

Corresponde a medidas gerais, educativas, que objetivam melhorar a resistência e o bem-estar geral dos indivíduos para que resistam às agressões dos agentes.

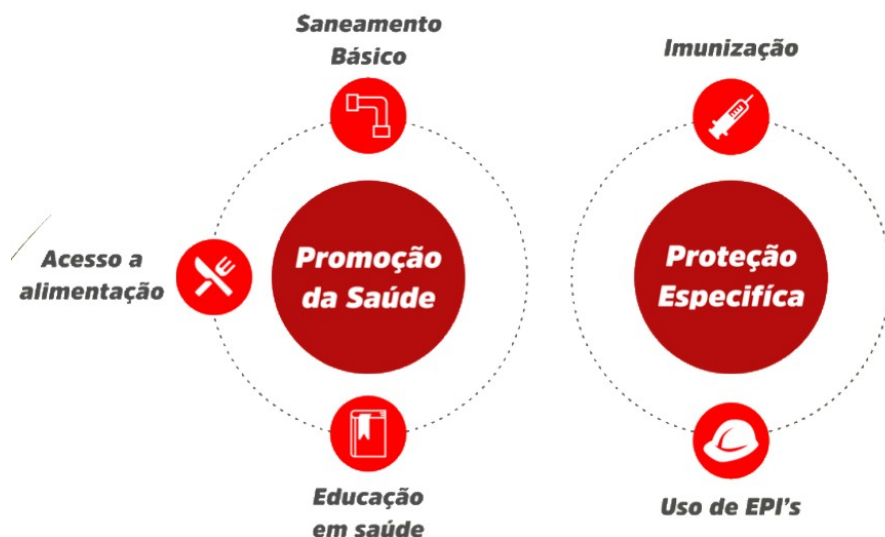
ANOTAÇÕES

03

ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA

Determinantes Sociais de Saúde – Processo Saúde-Doença (parte 3)

Também diz respeito a ações de orientação para cuidados com o ambiente, para que esse não favoreça o desenvolvimento de agentes etiológicos (comportamentos higiênicos relacionados à habitação e aos entornos).



SECUNDÁRIA

Engloba estratégias populacionais para detecção precoce de doenças.

Também contempla ações com indivíduos doentes ou acidentados com diagnósticos confirmados, para que se curem ou mantenham-se funcionalmente sadios, evitando complicações e mortes prematuras.

Isto se dá por meio de práticas clínicas preventivas e de educação em saúde, objetivando a adoção/mudança de comportamentos (alimentares, atividades físicas etc.).

TERCIÁRIA

Consiste no cuidado de sujeitos com sequelas de doenças ou acidentes, visando a recuperação ou a manutenção em equilíbrio funcional.



TABELA SOBRE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS EM SAÚDE BUCAL NO FINAL DO RESUMO

O MOVIMENTO MODERNO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE

Marc Lalonde, Ministro da Saúde do Canadá na década de 1970, ao investigar o impacto dos investimentos e gastos em saúde na melhoria dos indicadores, constatou que 80% das causas das doenças estavam relacionadas a estilos de vida e ambiente.

Esse foi um disparador para o questionamento sobre a capacidade das ações sanitárias setoriais serem capazes de resolver os problemas de saúde.

Atribuição ao governo da responsabilidade por outras medidas, como o controle de fatores que influenciam o meio ambiente.

Assim, um processo de valorização e conceituação da promoção da saúde começou a surgir, a partir da demanda pelo controle dos custos crescentes referentes à assistência médica.

Nesse contexto, um conceito mais contemporâneo de promoção da saúde surgiu em **1986**, quando a **Organização Mundial da Saúde (OMS) promoveu a Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em Ottawa, Canadá.**

Esse encontro consistiu em uma resposta à crescente demanda por uma nova concepção de Saúde Pública no mundo, que pudesse responder à complexidade emergente dos problemas de saúde, cujo entendimento não era mais possível por meio do enfoque preventivista tradicional, mas que se relacionasse a questões como as condições e modos de vida.

Como produto da Conferência, foi emitida a **Carta de Ottawa para a Promoção da Saúde.**

CARTA DE OTTAWA PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE

A primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa em 21 de Novembro de 1986, aprovou a presente Carta, que contém as orientações para atingir a Saúde para Todos no ano 2000 e seguintes.

Esta Conferência foi, essencialmente, uma primeira resposta às crescentes expectativas no sentido de se conseguir um novo movimento de Saúde Pública, a nível mundial.

Foi durante este conferência que se definiu o que era a promoção da saúde.

Esta se define como o processo de fortalecimento e capacitação de indivíduos e coletividades, no sentido de que ampliem suas possibilidades de controlar os determinantes do PSa e, com isso, ensejem uma mudança positiva nos níveis de saúde.

Foi durante este conferência que se definiu o que era a promoção da saúde.

“Processo de fortalecimento e capacitação de indivíduos e coletividades, no sentido de que ampliem suas possibilidade de

controlar os determinantes do PSa e, com isso, ensebem uma mudança positiva nos níveis de saúde”.

A Carta de Ottawa propôs também cinco campos de ação principais para a Promoção da Saúde.

1. ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SAUDÁVEIS

Minimização das desigualdades por meio de ações sobre os determinantes dos problemas de saúde (equidade).

As políticas públicas saudáveis podem ser estabelecidas por qualquer setor da sociedade (intersectorialidade) e devem demonstrar potencial para produzir saúde socialmente.

Como exemplos de políticas saudáveis citamos o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Política Nacional de Promoção da Saúde do Ministério da Saúde.

2. CRIAÇÃO DE AMBIENTES FAVORÁVEIS A SAÚDE

Uma vez que a saúde seja reconhecida como socialmente produzida nos diferentes espaços de convivência, é fundamental que as escolas, os municípios, os locais de trabalho e de habitação sejam ambientes saudáveis.

3. REFORÇO DA AÇÃO COMUNITÁRIA

Engloba a participação social (Estado e sociedade civil) na elaboração e controle das ações de Promoção da Saúde e visa o empoderamento da comunidade.

Preza pelo fortalecimento das organizações comunitárias, pela redistribuição de recursos, pelo acesso a informações e pela capacitação dos setores marginalizados do processo de tomada de decisões.

4. DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PESSOAIS

Viabilizado por meio de estratégias educativas, são programas de formação e atualização que capacitam os indivíduos a participar, criar ambientes de apoio à Promoção da Saúde e desenvolver habilidades pessoais relacionadas à adoção de estilos de vida saudáveis.

5. REORIENTAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE

Esforços para a ampliação do acesso, para a efetivação da equidade e para a adoção de ações preventivas por meio da moderna abordagem da Promoção da Saúde.

Se analisarmos o histórico do conceito de Promoção da Saúde e, principalmente, as cartas e declarações resultantes das conferências internacionais sobre o tema, notaremos a tendência à adoção de uma visão global da saúde e ao entendimento da determinação social do processo saúde-doença e à compreensão da equidade social como objetivos a serem atingidos.

Assim, a intersetorialidade, a participação social para o fortalecimento da ação comunitária e a sustentabilidade são considerados como princípios ao se definirem estratégias de ação.

PRINCÍPIOS DA PROMOÇÃO DA SAÚDE ATUAIS

EQUIDADE

Garantir acesso universal à saúde, com justiça social. Para a construção de espaços de vida mais equitativos, são necessárias:

- a) a análise dos territórios onde as pessoas habitam;
- b) a detecção de grupos em situação de exclusão;
- c) a implementação de políticas públicas que façam uma discriminação positiva desses grupos.

Isso implica na criação de oportunidades para que todos tenham saúde, reconhecendo que as necessidades são diferenciadas, uma vez que sofrem interferência dos determinantes de saúde na população.

INTERSETORIALIDADE

Articula saberes e experiências no planejamento, execução e avaliação de ações para alcançar efeito sinérgico em situações complexas.

O desafio colocado para a concretização da intersetorialidade é o modelo tradicional de fragmentação e desarticulação das ações.

É necessária uma mudança radical das práticas e da cultura organizacional das administrações, pressupondo a superação da fragmentação na gestão das políticas públicas.

PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Diz respeito ao envolvimento dos cidadãos no planejamento, execução e avaliação dos projetos.

Para que essa participação seja qualificada, torna-se necessário o empoderamento coletivo, para que a população se torne capaz de exercer controle sobre os determinantes da saúde.

ANOTAÇÕES

04

ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA

Determinantes Sociais de Saúde – Processo Saúde-Doença (parte 4)

SUSTENTABILIDADE

A promoção da saúde trabalha com questões de natureza complexa, demanda processos de transformação coletivos, com impactos a médio e longo prazos.

Almeja-se a criação de iniciativas de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável e a garantia de processo duradouro e forte.

PROMOÇÃO DA SAÚDE X PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Nesse momento, é importante salientarmos a diferença entre prevenção de doenças e promoção da saúde, lembrando que ambas são importantes para a condição de saúde.

Prevenção de doenças: Trabalha no sentido de garantir proteção a doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência nas populações;

Promoção da saúde: visa incrementar a saúde e o bem-estar gerais, promovendo mudanças nas condições de vida e de trabalho capazes de beneficiar a saúde de camadas mais amplas da população, ou seja, facilitar o acesso às escolhas mais saudáveis.

A promoção da saúde deve possuir enfoque mais amplo e abrangente, pois deve trabalhar a partir da identificação e enfrentamento dos macrodeterminantes do PSa, procurando transformá-los favoravelmente na direção da saúde.

Para a PREVENÇÃO, evitar a doença é o objetivo final.

Para a PROMOÇÃO, o objetivo é CONTÍNUO é o nível ótimo de vida e de saúde, portanto ausência de doenças não suficiente.

PREVENÇÃO QUATERNÁRIA

As ações em saúde, tanto preventivas quanto curativas, têm sido consideradas, em algumas situações, excessivas e agressivas, tornando-se também um fator de risco para a enfermidade e a doença.

Por essa razão, em 1995, Jamoulle e Roland propuseram o conceito de Prevenção Quaternária (Prevenção da iatrogenia), em 1999.

Esse novo nível de prevenção pressupõe ações clínicas centradas na pessoa, e pautadas na epidemiologia clínica e na saúde baseada em evidências, visando melhorar a qualidade da prática em saúde, bem como a racionalidade econômica.

Portanto, as ações devem ser cultural e cientificamente aceitáveis, necessárias e justificadas, prezando pelo máximo de qualidade da atenção com o mínimo de quantidade/intervenção possível.

Outro objetivo da prevenção quaternária é construir a autonomia dos usuários e pacientes por meio de informações necessárias e suficientes para poderem tomar suas próprias decisões, sem falsas expectativas, conhecendo as vantagens e os inconvenientes dos métodos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos propostos.

Em suma, consiste na construção da autonomia dos sujeitos e na detecção de indivíduos em risco de sobretratamento ou excesso de prevenção, para protegê-los de intervenções profissionais inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis.

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Foi definida então como “atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos práticos, cientificamente comprovados e socialmente aceitos, tornados universalmente acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade, a um custo que tanto a comunidade quanto o país possa arcar em cada estágio de seu desenvolvimento.

É parte integral do sistema de saúde do país, do qual é função central, sendo o enfoque principal do desenvolvimento social e econômico global da comunidade.

É o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro elemento de um processo de atenção continuada à saúde”.

Definiram-se, também, os elementos essenciais da APS para aquele momento histórico, como apontado anteriormente, sendo muitos deles similares aos dos centros de saúde comunitários:

PONTOS-CHAVE

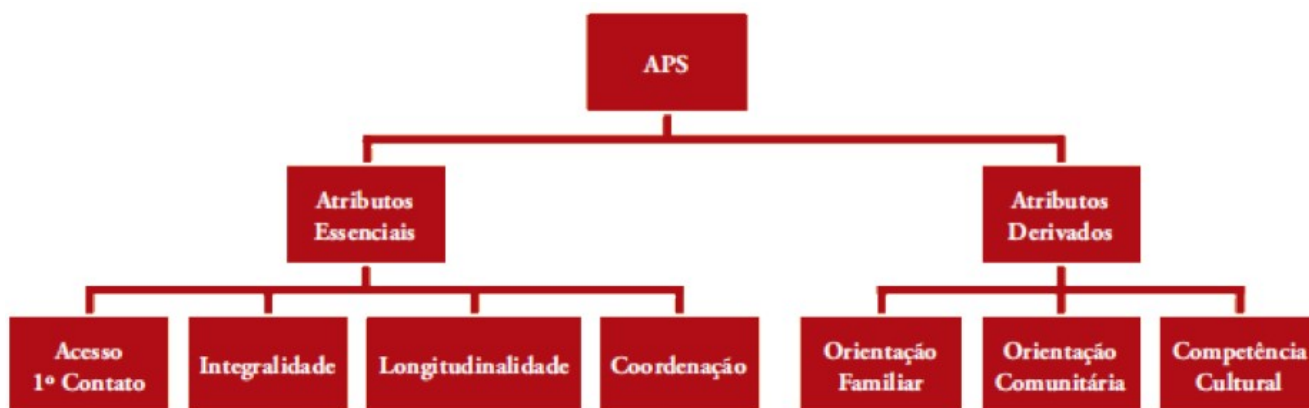
- educação em saúde conforme as necessidades locais;
- promoção de nutrição adequada;
- abastecimento de água e saneamento básico apropriados;
- atenção materno-infantil (incluindo o planejamento familiar);
- imunização;
- prevenção e controle das doenças endêmicas;
- tratamento apropriado das doenças comuns e acidentes na comunidade, e distribuição de medicamentos básicos e essenciais.

PRINCÍPIOS MODERNOS DA APS

Os princípios da APS em quatro características essenciais (primeiro contato, integralidade, longitudinalidade e coordenação), mais três derivados (orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural);

Assim, a APS deve ser o primeiro contato preferencial das pessoas com o sistema de saúde, sem restrição de acesso às mesmas, independente de gênero, condições socioculturais e problemas de saúde; com abrangência e integralidade das ações individuais e coletivas; e continuidade (longitudinalidade) e coordenação do cuidado ao longo do tempo, tanto no plano individual, quanto no coletivo, mesmo quando houver necessidade de referenciamento das pessoas para outros níveis e equipamentos de atenção do sistema de saúde.

Deve ser praticada e orientada para o contexto familiar e comunitário, entendidos em sua estrutura e conjuntura socioeconômica e cultural.



Sabe-se hoje, por diversos estudos científicos, que um sistema de saúde com forte referencial na APS é mais efetivo, mais satisfatório para as pessoas e comunidades, tem menores custos, e é mais equitativo – mesmo em

contextos de grande iniquidade social;

Assim, a APS vem sendo entendida como o primeiro nível de atenção nos sistemas de saúde nacionais, regionais e locais, como também como estratégia política e princípios para a (re)organização dos serviços e sistemas de saúde.

Para tal, necessita de práticas profissionais específicas e construídas em um modo complexo, integral e sistêmico de pensar o PSa, incorporando o conceito mais moderno de promoção da saúde.

ELEMENTOS ESSENCIAIS DA APS

Educação em saúde conforme as necessidades locais;
 Promoção de nutrição adequada;
 Abastecimento de água e saneamento básico apropriados;
 Atenção materno-infantil (incluindo o planejamento familiar);
 Imunização;
 Prevenção e controle das doenças endêmicas;
 Tratamento apropriado das doenças comuns e acidentes na comunidade, e distribuição de medicamentos básicos e essenciais.

Prevenção primária		Prevenção secundária	Prevenção terciária	
Promoção de saúde	Proteção específica	Diagnóstico precoce e tratamento	Incapacidade funcional	Reabilitação
Educação em saúde bucal Educação para exames dentais periódicos Bom padrão de nutrição, fases de desenvolvimento da vida regulares Atenção ao desenvolvimento pessoal Aconselhamento genético Fornecimento de condições ótimas de moradia	Atenção à higiene oral pessoal Uso de controles ambientais, como fluoretação da água, aplic. Tóp. fluoretos, e outras medidas preventivas Proteção contra riscos ocupacionais e de lazer, como o uso de protetores bucais Uso de nutrientes essenciais específicos (no qual o flúor é um) Proteção contra agentes carcinogênicos, tais como medidas anti-fumo	Medidas de achados clínicos, tais como radiografias Proteção nos exames, tal como programas de proteção ao câncer bucal Sistemas de retorno às consultas Tratamento de dentes cariados Limpeza profissional dos dentes Eliminação de infecções Fornecimento de aparelhos ortodônticos e mantenedores de espaço	Tratamento e controle das cáries dentais e doença periodontal e prevenção de maiores complicações e seqüelas Fornecimento de aparelhos para restaurar função e estética Tratamento de outras doenças e condições orais	Educação dos indivíduos para o uso apropriado de dentaduras Educação pré e pós-cirúrgica para pacientes de cirurgia oral

O processo educacional deve ser aplicado continuamente em todos os níveis de prevenção.

ANOTAÇÕES

Epidemiologia

Odontologia em Saúde Coletiva

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 4

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Epidemiologia em Saúde Coletiva	3
--	---

01

ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA

Epidemiologia em Saúde Coletiva

Aula ministrada pelo Dr. Prof Marcos Antônio Lima dos Santos, em 16 de agosto, na Universidade Cidade de São Paulo.

Introdução

Ter o conhecimento da distribuição de uma doença na população, e para isso deve-se conhecer os aspectos epidemiológicos, patológicos, imunológicos e clínicos. Ela é a ciência básica da Saúde Coletiva. É o estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas e dos determinantes relacionados.

Mas nem foi sempre assim, a história da EPIDEMIOLOGIA acompanha a história da MEDICINA. Hipócrates lançou as principais bases dos estudos epidemiológicos. Foi o primeiro a sugerir que as causas das doenças não eram intrínsecas a pessoa nem aos desígnios divinos, mas que estavam relacionadas a características ambientais.

Histórico

Traz os termos epidêmico e endêmico.

Epidemion (verbo que significa visitar: enfermidades que visitam) e *Endemion* (residir enfermidades que permanecem na comunidade).

PONTOS-CHAVE

- Epidemia;
- Pandemia;
- Endemia;
- Surto;

EPIDEMIA: Quando ocorre um aumento no número de casos de uma doença em várias regiões, mas sem uma escala global.

PANDEMIA: Disseminação mundial de uma doença.

ENDEMIA: Quando uma doença tem recorrência em uma região, mas sem aumentos significativos no número de casos.

SURTO EPIDÊMICO: Aumento repentino e inesperado de casos de uma doença em uma determinada região, comunidade ou estação do ano.

A partir das primeiras décadas do século XX:

- Melhoria do nível de vida nos países desenvolvidos;
- Consequente declínio na incidência das doenças infecciosas;
- Outras enfermidades de caráter não-transmissível passaram a ser incluídas entre os objetos de estudos epidemiológicos.

Hoje a epidemiologia constitui importante instrumento para a pesquisa na área da saúde, seja no campo da clínica, seja no da saúde pública.

No Brasil, a organização dos serviços do SUS baseia-se na descentralização, sendo indispensável o conhecimento da epidemiologia nos serviços locais de saúde.

A epidemiologia é a distribuição de doenças no espaço e no tempo.

QUEM?

Características pessoas:

Sexo;
Idade (o sarampo, por exemplo, é mais comum em crianças).
Raça;
Condição socioeconômica;
Hábitos alimentares;
Hábitos culturais.

ONDE?

Analisa a possibilidade de haver padrões espaciais na distribuição de doenças (como por exemplo, a diarreia infecciosa mais prevalente em áreas sem saneamento básico).

Áreas específicas para manifestação das doenças.

QUANDO?

Avalia as tendências e os períodos de maior ocorrência das doenças (como por exemplo, a dengue é mais comum no verão)

Velocidade da ocorrência (como por exemplo, a mortalidade do câncer gástrico vem declinando nos últimos 50 anos).

Evolução temporal pode prever sua ocorrência futura.



Distribuição das doenças no espaço

Aplicabilidade

Melhor conhecimento do processo saúde-doença.

Definição de grupos mais vulneráveis.

Determinar as áreas de risco para intervenção em saúde.

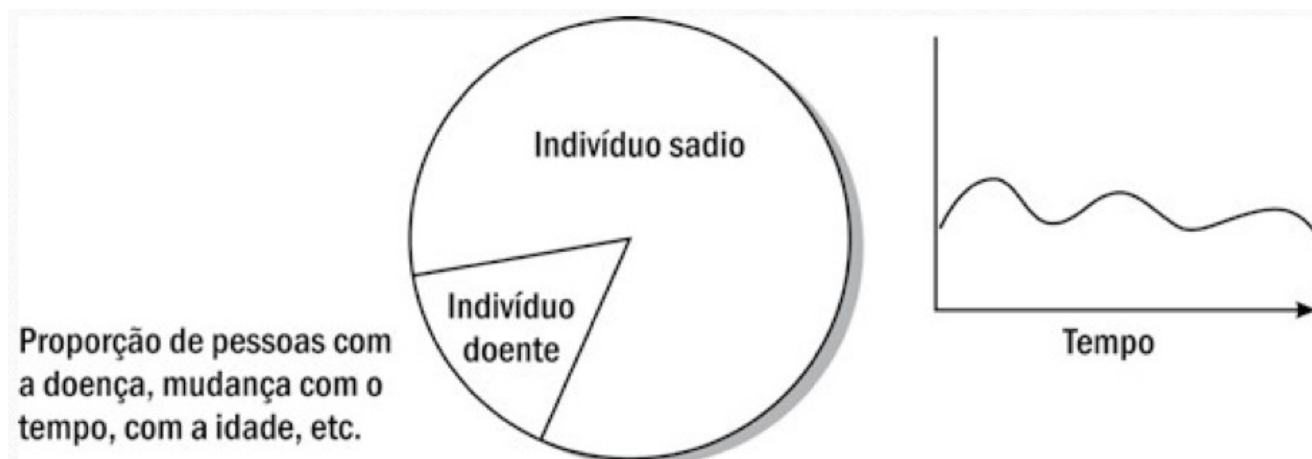
Avaliar o impacto das intervenções em saúde.

Planejamento: Onde e como empregar recursos públicos.

Quadro 1 – Principais diferenças entre as abordagens clínica e epidemiológica

	Clínico	Epidemiológico
Tipo de diagnóstico	Individual	Comunitário/populacional
Objetivo	Curar e prevenir a doença da pessoa	Melhorar o nível de saúde da comunidade/identificar fatores risco...
Informação necessária	História Clínica Exame Físico Exames Complementares	Dados populacionais Dados com referência de tempo e espaço geográfico de causas de morte, serviços de saúde, incapacidade, fatores risco...
Ações	Tratamento Reabilitação	Programas de saúde/promoção
Monitoramento no tempo	Acompanhamento clínico (evitar doenças/melhorar/curar a pessoa)	Mudanças no estado de saúde da população bem como diminuição das taxas de mortalidade, da incidência de doenças...

Estado de saúde das populações



A epidemiologia é frequentemente utilizada para descrever o estado de saúde de grupos populacionais.

O conhecimento da carga de doenças que acompanha a população é essencial para as autoridades em saúde.

Esse conhecimento permite melhor utilização de recursos através da identificação de programas curativos e preventivos prioritários à população.

Medir saúde e doença

Medir saúde e doença é fundamental para a prática da epidemiologia.

Diversas medidas são utilizadas para caracterizar a saúde das populações.

O estado de saúde da população não é totalmente medido em muitas partes do mundo, e essa falta de informações constitui um grande desafio.

Para avaliar o nível de saúde de uma população buscam-se os dados negativos (não-saúde): MORTE, DOENÇA e AGRAVOS.

Incidência

É a taxa de manifestação de uma determinada doença.

Mensura o surgimento da doença.

Número de casos novos de uma doença que surgem em uma população durante um período determinado de tempo.

$$\text{INCIDÊNCIA} = \frac{\text{Número de casos novos em determinado período}}{\text{Número de pessoas expostas ao risco no mesmo período}} \times \text{CONSTANTE}$$

EXEMPLOS:

1. Numa população hipotética de 100 indivíduos, 10 estão sendo tratados para hepatite C desde 2021 e 3 foram diagnosticados em 2022. Qual a incidência de hepatite nesta população? R: 3%
2. Numa população hipotética de 150 indivíduos, 24 estão passando por tratamento para periodontite severa desde 2019 e 8 foram diagnosticados em 2020. Qual a incidência de periodontite severa nesta população? R: 5,3%

Prevalência

É o número de casos de uma doença em uma população, durante um período específico de tempo.

$$\text{PREVALÊNCIA} = \frac{\text{Número de casos novos e pré-existent em determinado período}}{\text{Número de pessoas expostas ao risco no mesmo período}} \times \text{CONSTANTE}$$

Mede a proporção da população que já tem a doença.

Proporção de indivíduos de uma população afetados por uma enfermidade em um momento ou período de tempo determinado .

EXEMPLOS:

1. Numa população hipotética de 100 indivíduos, 10 estão sendo tratados para hepatite C desde 2021 e 3 foram diagnosticados em 2022. Qual a prevalência de hepatite nesta população? R: 13%
2. Numa população hipotética de 150 indivíduos, 24 estão passando por tratamento para periodontite severa desde 2019 e 8 foram diagnosticados em 2020. Qual a prevalência de periodontite severa nesta população? R: 21,33%

Dados

Registro dos dados:

Forma **contínua**: óbitos, nascimentos, doenças de notificação obrigatória.

Forma **periódica**: determinação de habitantes de uma população.

Forma **ocasional**: pesquisas realizadas com fins específicos: Conhecer a prevalência da hipertensão arterial em uma comunidade, em determinado momento.

DADOS RELEVANTES A SAÚDE:

População: número de habitantes, idade, sexo, etc;

Sócio-econômicos: renda, ocupação, classe social, tipo de trabalho, condições de moradia e alimentação;

Ambientais: poluição, abastecimento de água, tratamento de esgoto, coleta e disposição de lixo;

Morbidade: ocorrência de doenças e gravidade do processo mórbido;

Serviços de saúde: hospitais, ambulatorios, unidades de saúde, acesso aos serviços;

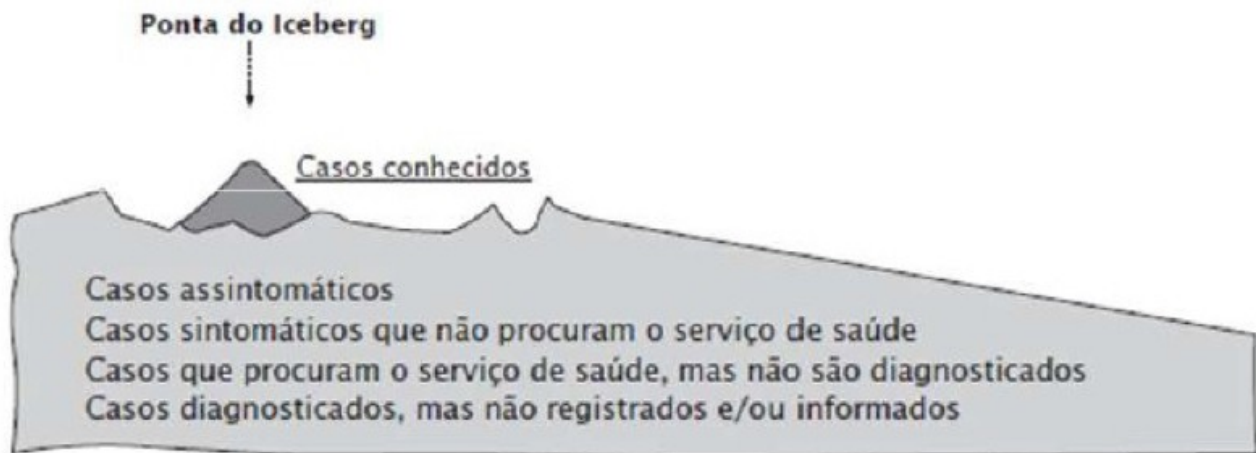
LIMITAÇÕES: “ponta do iceberg”

Refere-se a uma característica desses dados, ou seja, mortalidade (especialmente a última) representam apenas uma parcela da população.

A que morre.

Chega ao serviço de saúde.

Tem seu diagnóstico feito e registrado corretamente;

**PRINCIPAIS OBJETIVOS DA EPIDEMIOLOGIA:**

1. Descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde das populações humanas.
2. Proporcionar dados essenciais para o planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, controle e tratamento das doenças, bem como para estabelecer prioridades.
3. Identificar fatores etiológicos na gênese das enfermidades.

- **EPIDEMIA:** ocorrência coletiva de uma doença, elevando significativamente a incidência;
- **ENDEMLIA:** ocorrência coletiva de uma doença, com incidência constante;
- **PANDEMLIA:** é uma epidemia que atinge várias nações;
- **SURTO EPIDÊMICO:** é uma ocorrência epidêmica restrita a um espaço delimitado;

ANOTAÇÕES

Estudos Epidemiológicos

Odontologia em Saúde Coletiva

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 5

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Estudos Epidemiológicos	3
02 Estudos Epidemiológicos (parte 2)	8
03 Estudos Epidemiológicos (parte 3)	14
04 Estudos Epidemiológicos (parte 4)	19

01

ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA

Estudos Epidemiológicos

Aula ministrada pelo Dr. Prof Marcos Antônio Lima dos Santos, em 23 de setembro, na Universidade Cidade de São Paulo.

Os desenhos epidemiológicos podem ser classificados genericamente em estudos: 1. Descritivos. 2. Analíticos.

Descritivos

É quando se limitam a fornecer informações sobre a distribuição de um acontecimento ou evento em uma população.

Investigam a frequência e distribuição de um agravo à saúde na população segundo as características da própria população.

PONTOS-CHAVE

Relato de casos;

Relato de caso clínico

Reabilitação estética e funcional em paciente com cárie severa da infância: relato de caso

Séries de casos;

Tumores nasossinusais raros: série de casos e revisão de literatura

Rare nasosinusal tumors: Case series and literature review

Estudos transversais ou de prevalência;

Quando se referem à medição de problemas em determinado momento.

A exposição e a condição de saúde do participante são determinadas simultaneamente.

Em geral, esse tipo de investigação começa com um estudo para determinar a prevalência de uma doença ou condição relacionada à saúde de uma população especificada.

Acesso aos serviços de saúde para o diagnóstico e tratamento da tuberculose entre povos indígenas do estado de Rondônia, Amazônia Brasileira, entre 2009 e 2011: um estudo transversal*

Objetivo: investigar o acesso aos serviços de saúde para diagnóstico e tratamento da tuberculose (TB) entre indígenas atendidos no estado de Rondônia, Brasil, 2009-2011. **Métodos:** estudo transversal, realizado nas Casas de Saúde Indígena (Casai), entre outubro/2009 e fevereiro/2011; investigou-se, mediante entrevistas, as dimensões geográfica, econômica e funcional do acesso aos serviços de TB, apresentadas descritivamente. **Resultados:** foram entrevistados 52 indígenas com TB; na dimensão geográfica, transporte, distância e ausência de profissionais foram as principais barreiras; na econômica, 15 indígenas relataram custos/despesas para receber atendimento; na funcional, 21 chegaram à Casai por conta própria; o tempo entre primeiros sintomas e chegada à Casai foi >30 dias em 24 relatos, e entre primeira consulta e início do tratamento, >30 dias em 25 relatos; houve tratamento supervisionado em 22 casos. **Conclusão:** as dificuldades observadas para acessar os serviços de saúde, nas dimensões analisadas, podem contribuir para a manutenção da transmissão da TB nas aldeias.

Estudos ecológicos

Compara-se a ocorrência da • condição relacionada à saúde e a exposição de interesse entre agregados de indivíduos, para verificar a possível existência de associação entre elas.

A unidade de observação é a população ou comunidade.

Nesse tipo de estudo, não existem informações sobre a doença e exposição do indivíduo, mas do grupo populacional como um todo.

Cobertura radiográfica odontológica pelo Sistema Único de Saúde na região Sul do Brasil em 2016: estudo ecológico

doi: 10.5123/S1679-49742019000100005

Objetivo: investigar a cobertura de equipamentos radiográficos odontológicos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nos municípios da região Sul do Brasil em 2016 e a realização de procedimentos radiográficos nos municípios que dispõem desses equipamentos. **Métodos:** foi realizado estudo ecológico com dados do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (unidades básicas de saúde com consultório odontológico, disponibilidade e funcionamento dos equipamentos radiográficos e realização de radiografias) e da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (população); foram realizados o teste do qui-quadrado e análise de variância. **Resultados:** 984 equipamentos radiográficos odontológicos foram identificados em 479 dos 1.191 municípios analisados; 60% dos municípios não apresentaram equipamentos, 68% apresentaram cobertura menor que a recomendada e 52% dos municípios com equipamentos não realizaram nenhum exame radiográfico durante o ano de 2016. **Conclusão:** menos da metade dos municípios possuíam equipamentos radiográficos odontológicos; entre os que tinham esses equipamentos, metade não realizou nenhum procedimento.

Analíticos

Constituem uma etapa posterior à representada pelo método descritivo, destinando-se a explicar causas e efeitos, testando hipóteses;

Permitem calcular medidas de associação;

Caso-Controlle, Coorte, Ensaios Clínicos Randomizados.

Estudos do Coorte

São conhecidos como de incidência ou longitudinais, visto que a informação obtida abrange a evolução do problema em certo período;

Grupo de pessoas, a partir de uma mesma situação inicial, passa a ser acompanhada para observar quais membros desenvolvem ou não determinada característica ou doença.

Mortalidade neonatal precoce no município de Caxias do Sul: um estudo de coorte

Objetivo: Estabelecer o perfil dos neonatos de Caxias do Sul e estudar a mortalidade neonatal precoce, suas causas e as variáveis a esta relacionadas.

Métodos: Estudo de coorte envolvendo 5.545 recém-nascidos acompanhados por até 7 dias de vida. Calculou-se a probabilidade de morte neonatal precoce (PMNP), utilizando-se a regressão logística múltipla para relacionar as variáveis estudadas com a mortalidade neonatal precoce.

gar < 7, sexo masculino e baixo peso. A principal causa de óbito foi a doença da membrana hialina, seguida pelas cardiopatias congênitas, prematuridade extrema e descolamento prematuro de placenta.

Conclusão: Apesar da PMNP ter sido baixa, ocorreram mortes que poderiam ter sido evitadas com um melhor atendimento no pré-natal, no parto e na assistência ao RN.

Estudos de Caso-Controlle

Quando baseados na formação de grupos semelhantes comparados entre si após serem submetidos ou não a um método preventivo ou a determinadas condições durante um período.

O grupo-controle necessariamente deve apresentar as mesmas características que o grupo-teste.

Comparam-se os resultados entre os dois grupos por meio de uma razão de risco ou pelo *odds ratio*. **ODDS RATIO = PROBABILIDADE** A = total expostos à situação e à condição. B = total expostos geral. C = total não expostos à situação e à condição. D = total não expostos geral.

$$OR_{\text{casos e controles}} = \frac{\frac{a}{c}}{\frac{b}{d}} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

Associação entre consumo regular de café e doença periodontal (estudo de coorte)*

Consumo de café	Doença periodontal		
	Sim	Não	Total
Sim	20	30	50
Não	10	40	50
Total	30	70	100

Risco relativo (RR) = $(20/50)/(10/50)$
= **2,00**
(IC95%: 1,04-3,83; p=0,03)

Tabagismo	Doença periodontal		
	Sim	Não	Total
Sim	6	4	10
Não	4	36	40
Total	10	40	50

Risco relativo (RR) = $(6/10)/(4/40)$
= **6,00**
(IC95%: 2,08-17,29; p<0,00)

Tabagismo	Consumo de café		
	Sim	Não	Total
Sim	30	10	40
Não	20	40	60
Total	50	50	100

Risco relativo (RR) = $(30/40)/(20/60)$
= **2,25**
(IC95%: 1,51-3,36; p<0,00)

Fatores maternos para o nascimento de recém-nascidos com baixo peso e prematuros: estudo caso-controle

Objetivo: Identificar os fatores maternos mais associados ao nascimento de recém-nascidos com baixo peso e prematuros.

Materiais e Métodos: Estudo caso-controle com 111 puérperas que buscaram atendimento em um hospital público de Feira de Santana (BA). O grupo caso foi constituído por mães de neonatos com baixo peso (<2500g) e <37 semanas, e o grupo controle, por mães de neonatos com peso normal (≥2500g) e a termo. O peso ao nascer e idade gestacional foram obtidos através do registro hospitalar. Os principais fatores de risco para o BPN e prematuridade foram avaliados mediante análise bivariada e obtenção da medida de associação odds ratio (OR).

Resultados: 18,9% das puérperas tiveram filhos prematuros e, em 38,1% dos casos, o parto ocorreu antes de 34 semanas. A maioria dessas mulheres tinha idade entre 14 e 25 anos (66,7%), cor negra ou parda (85,7%), com companheiro (81,0%), tiveram o parto normal (57,0%) e visitaram o dentista durante a gestação (95,2%). Houve associação estatisticamente significativa entre baixo peso ao nascer/parto prematuro e o consumo de bebida alcoólica (OR: 7,9; p=0,001), número de consultas pré-natais menor que 6 (OR: 2,94; p=0,02) e uso de medicação abortiva (OR: 5,05; p=0,04).

Conclusão: Os achados demonstraram que as mulheres que consumiam bebida alcoólica, que realizaram menos de seis consultas pré-natais e usavam medicação abortiva, tiveram maior chance do bebê nascer com baixo peso e prematuro. Assim, esses fatores de risco merecem atenção especial nas políticas públicas para o enfrentamento desse agravos.

Ensaio Clínico Randomizados

Dois grupos são formados de maneira aleatória (randômica, ao acaso) para assegurar que tenham características semelhantes, um de estudo e outro de controle.

Em seguida, atua-se em um dos grupos de maneira a poder comparar resultados com o que não foi submetido a nenhuma intervenção.

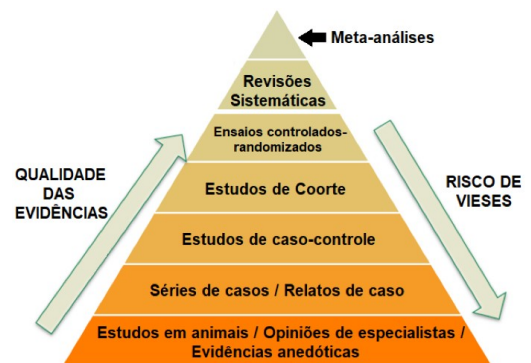
Ação da Própolis de *Apis mellifera* Associada ao Fluoreto de Sódio Sobre o Biofilme Dental: Ensaio Clínico Duplo Cego Randomizado

The Effect of *Apis mellifera* Propolis Associated With Sodium Fluoride on Dental Biofilm: Randomized Double-Blind Clinical Trial

Objetivo: Avaliar a ação do Extrato Etanólico de Própolis 5% isoladamente e combinado ao fluoreto de sódio sobre o acúmulo do biofilme dental, e consequentemente, sobre a atividade de cárie. **Material e Método:** Nesse ensaio clínico duplo cego randomizado, participaram 97 escolares, os quais foram aleatoriamente divididos em Grupo I e Grupo II, sendo submetidos, respectivamente, à aplicação tópica do Gel A (Própolis 5% + NaF 0,05%) e do Gel B (Própolis 5%). A contagem dos níveis salivares de *Streptococcus mutans*, o acúmulo de biofilme (IHO-S) e a quantificação das manchas brancas ativas foram analisados antes e após a aplicação dos géis experimentais. **Resultados:** Am-

os os géis suprimiram as contagens salivares de *Streptococcus mutans* e o acúmulo do biofilme dental, sem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, enquanto somente o Gel A foi capaz de inativar significativamente as manchas brancas. **Conclusão:** A própolis associada ao fluoreto de sódio foi eficiente na redução do acúmulo de biofilme e dos níveis salivares de *Streptococcus mutans*, tendo destacada ação na remineralização de manchas brancas.

PALAVRAS-CHAVE: Própolis, fluoreto de sódio, biofilme dental, manchas brancas



Principais agravos em saúde bucal

A prestação de serviços de saúde bucal deve priorizar os agravos de maior gravidade e/ou mais prevalentes.

Os principais agravos que acometem a saúde bucal no Brasil e que têm sido objeto de estudos epidemiológicos em virtude de sua prevalência e gravidade são:

- Cárie dentária;
- Doença periodontal;
- Edentulismo;
- Mal oclusão;
- Câncer de boca;
- Fluorose dentária;
- Traumatismos dentários.

Outras patologias também são monitoradas em âmbito mundial e podem ser alvo das equipes de saúde, dependendo das peculiaridades locais.

- Erosão dental;
- Alterações bucais relacionadas ao vírus da imunodeficiência humana (HIV).

Cárie dentária

A doença cárie é a doença bucal mais prevalente no mundo.

Não-infecciosa, não-transmissível, açúcar-dependente e de caráter biossocial.

Diferentes açúcares como fonte de energia.

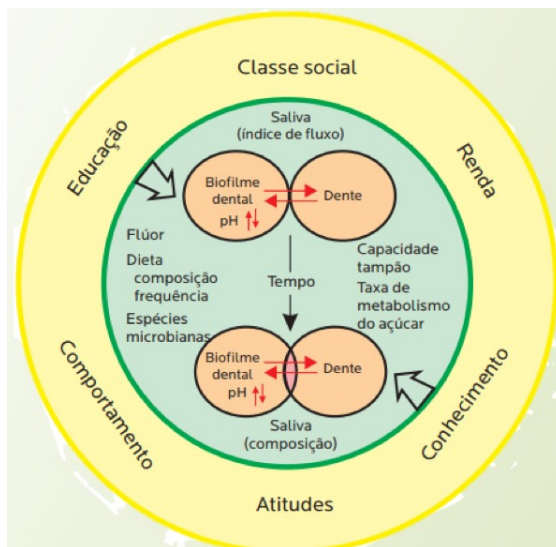
Streptococcus mutans (S. mutans) e Lactobacillus spp.

ANOTAÇÕES

02

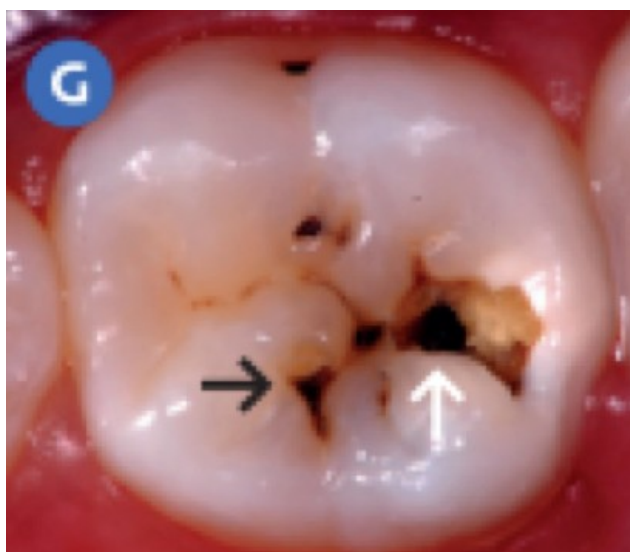
ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA

Estudos Epidemiológicos (parte 2)



PONTOS-CHAVE

CLASSIFICAÇÃO DA LESÃO DE CÁRIE Quanto à localização



Coronária



Radicular

Quanto ao sítio anatômico



Lesão de superfície lisa



Lesão de fóssulas e fissuras *Quanto à presença de cavidade*



Quanto ao tecido envolvido



Quanto à atividade



Quanto à presença ou não de restauração prévia



Primária



Secundária

EPIDEMIOLOGIA DA DOENÇA CÁRIE

Índices para a Cárie dentária.

Indica condição dentária e necessidades de tratamento.

Os índices mais utilizados e recomendados são:

CPO-D

Demonstra a história anterior do ataque da doença;

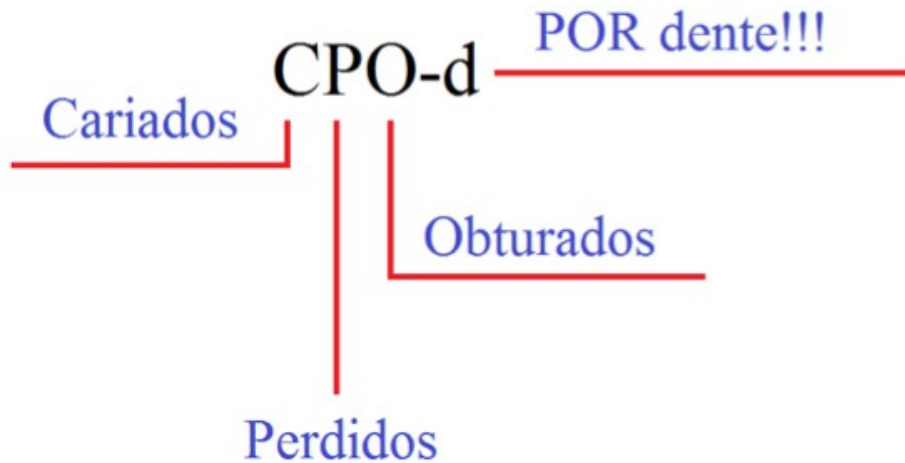
Restaurações e extrações por motivo de cárie;

Demonstra a história atual do ataque da doença;

Presença de cavitações;

Em indivíduos ou em grupos de indivíduos;

Mede a frequência da doença;



O índice de cada indivíduo será dado pela somatória dos dentes cariados, perdidos e obturados, ou seja, por aqueles que foram **atingidos por cárie, no presente e no passado**.

ÍNDICE CPO-D EM INDIVÍDUOS DE 12 ANOS:

Utilizado pela OMS como indicador básico de comparação internacional para o estado de saúde bucal das populações.

CPO-D	PREVALÊNCIA
0,0 — 1,1	Muito baixo
1,2 — 2,6	Baixo
2,7 — 4,4	Moderado
4,5 — 6,5	Alto
+/- 6,6	Muito alto

Valores elevados de CPO-D indicam más condições de saúde bucal da população.

Associado frequentemente a:

- Condições socioeconômicas desfavoráveis;
- Dificuldade de acesso ao serviço;
- Hábitos prejudiciais (açúcar, fumo);
- Limitado acesso ao flúor;

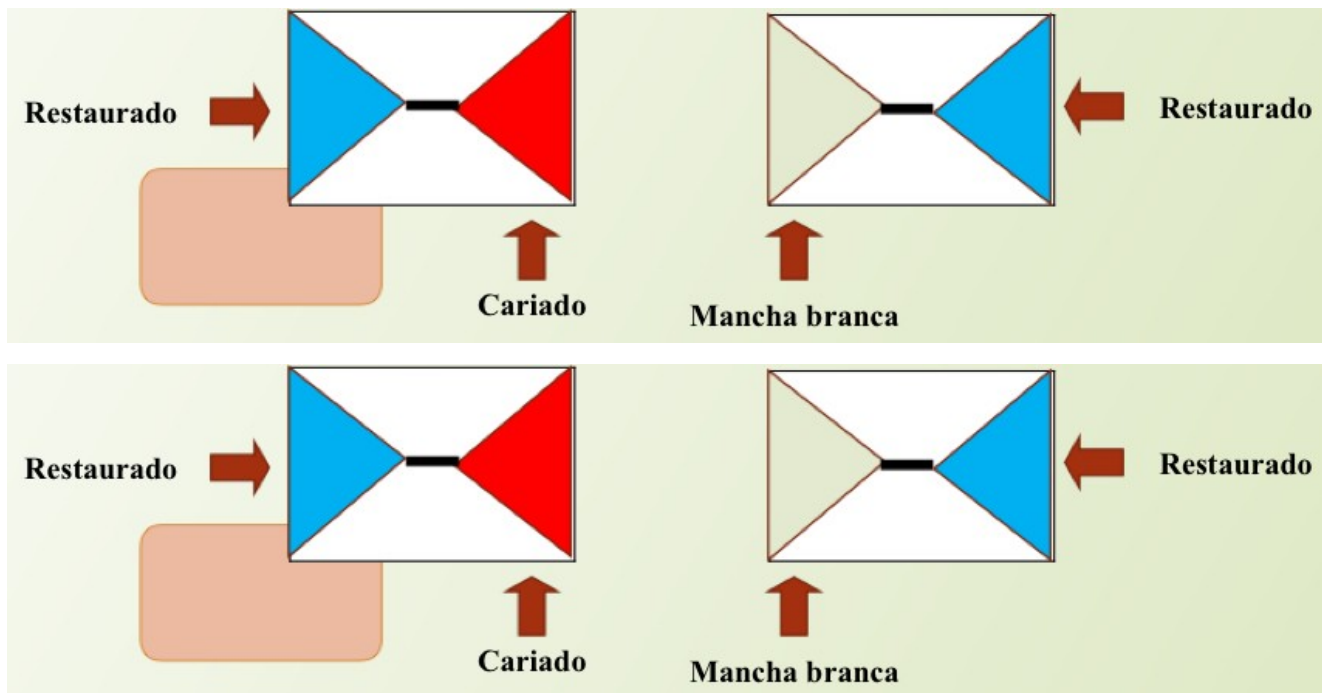
Utilizado para:

- Contribuir para avaliação das ações de prevenção da cárie dental;
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações voltadas à melhoria da saúde bucal;
- Comparar situação de saúde bucal de anos diferentes.

Regras índice CPO-D:

- Considerar a pior condição do dente.

Para o CPO-D, usamos o dente como um todo para a classificação do elemento. Assim, a pior situação será considerada.



Manchas brancas ativas são consideradas como cárie CLINICAMENTE.

No índice CPO-D, somente cavitações EVIDENTES são consideradas no componente C.

Além dos dentes que foram extraídos, também são considerados PERDIDOS (P) elementos com:

Necrose pulpar;

Extensa destruição coronária;

Extração indicada;

São considerados no componente obturados (O) dentes:

Restauração direta;

Restauração indireta;

Limitações do CPO-D

Possibilidade de interpretações distintas dos estágios iniciais de cárie, por parte dos examinadores;

Importante calibração.

Subestimação do índice quando as cáries do esmalte deixam de ser consideradas;

É obtido mediante exame restrito à coroa do dente, que não permite identificar as cáries radiculares.

ANOTAÇÕES

03

ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA

Estudos Epidemiológicos (parte 3)

EXEMPLO: Em consulta odontológica, G.C.C., de 56 anos, sexo feminino cuja queixa principal era história de mobilidade no dente 33. Ao exame clínico, observou-se prótese superior com rachadura. Raízes residuais dos elementos 37 e 47. Elementos ausentes 46 e 36. De acordo com a norma de classificação do CPO-D, o CPO-D de G.C.C. é:

A) 16. B) 18. **C) 20.** D) 21. E) 22.

Índice CPO-D Comunitário

É a média do número total de dentes permanentes cariados, perdidos e obturados, dividido pelo número de indivíduos examinados.

Cárie dentária, índice periodontal comunitário e higiene oral em população ribeirinha

Dental caries, community periodontal index and oral hygiene in a riverside community

Tabela 1. Índice CPO-D e ceo-d, desvio-padrão e livres de cárie, por faixa etária, na população rural ribeirinha. Rio Machado e Rio Preto (RO), 2006.

Faixa etária	n	CPO-D	ceo-d	Livres de cárie (%)
4-5 anos	55	---	4,30 ($\pm 3,48$)	19,64
12 anos	51	2,65 ($\pm 3,01$)	0,38 ($\pm 1,27$)	30,76
18 anos	41	5,41 ($\pm 5,33$)	---	19,51
35-44 anos	67	17,74 ($\pm 8,61$)	---	2,98
65-74 anos	23	21,56 ($\pm 11,95$)	---	4,34

Tabela 2. Média e desvio-padrão dos componentes dos Índices ceo-d, CPO-D, por faixa etária, na população rural ribeirinha. Rio Machado e Rio Preto (RO), 2006.

Faixa etária	Componente		
	Cariado	Restaurado	Perdido
4-5 anos	4,20 ($\pm 3,44$)	0,11 ($\pm 0,49$)	0,00 ($\pm 0,00$)
12 anos	2,15 ($\pm 4,03$)	0,21 ($\pm 0,89$)	0,29 ($\pm 0,72$)
18 anos	3,17 ($\pm 3,69$)	0,71 ($\pm 1,75$)	1,54 ($\pm 2,89$)
35-44 anos	2,54 ($\pm 3,66$)	0,86 ($\pm 2,99$)	14,33 ($\pm 8,83$)
65-74 anos	1,96 ($\pm 3,13$)	0,04 ($\pm 0,20$)	19,56 ($\pm 11,92$)

Doença periodontal:

Doença infecto-inflamatória.

Processo de desequilíbrio entre as ações de agressão e defesa sobre os tecidos de sustentação e proteção do dente.

PONTOS-CHAVE

Gengivite;
Periodontite Crônica (antigamente);
Periodontite Agressiva (antigamente);

Utilizamos a sonda OMS

A GENGIVITE é uma inflamação multifatorial da gengiva, que tem como característica principal o sangramento à sondagem.

1. Associada somente ao biofilme dental;

Sítios com profundidade de sondagem menor ou igual a 3 mm, 10% ou mais de sítios com sangramento à sondagem, ausência de perda de inserção e de perda óssea radiográfica.

2. Mediada por fatores de risco sistêmicos ou locais;

Como a glicose em excesso, tabaco...

3. Associada a medicamentos;

Como antiepilético, fármacos bloqueadores do canal de cálcio, ciclosporina, contraceptivos orais de alta dose.

Suas características clínicas são:

Sangramento à sondagem;
Sinais e sintomas restritos à gengiva;
Não tem perda de inserção;
Biofilme inicial e/ou exacerba a lesão;
Rubor e edema;
Alteração do contorno;
Alteração da consistência;

Condições gengivais

“A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”.

“A saúde periodontal deve ser definida como um estado livre de doença periodontal que permite a um indivíduo funcionar normalmente e evitar consequências (mentais ou físicas) devido a doença atual ou passada.”

Determinamos a profundidade clínica de sondagem com a sonda milimetrada no sulco, e usamos o periograma para fazer as anotações (retração, valor positivo e aumento de gengiva, valor negativo)

Como classificar a presença de periodontite?

3 diferentes formas:

1. Histórico do paciente; 2. Presença de sinais de periodontite necrosante; 3. Presença ou ausência de alguma doença sistêmica que possa influenciar a resposta do hospedeiro.

Severidade e Complexidade	Extensão e Distribuição	Taxa de Progressão e Resposta antecipada ao tratamento
Estágio I	Localizada	Grau A
Estágio II	Generalizada	Grau B
Estágio III	Padrão molar/incisivo	Grau C
Estágio IV		

Estádios de periodontite

Levam em consideração a severidade e complexidade e antecipam a complexidade da terapia periodontal.

SEVERIDADE = perda de inserção clínica e de perda óssea verificada radiograficamente e pelo número de dentes perdidos devido à periodontite.

COMPLEXIDADE = dificuldade envolvida no controle da doença e na reabilitação funcional e estética da dentição do paciente.

Escore baseado na perda de inserção interproximal devido à periodontite e na perda óssea marginal.

Ele é atribuído baseado no dente mais afetado.

O escore da complexidade considera a presença de fatores:

Presença de bolsas periodontais profundas
Defeitos verticais
Envolvimento de furca
Mobilidade dental acentuada
Perda de dentes
Deficiência de rebordo
Perda da função mastigatória

ESTÁDIOS DA PERIODONTITE					
ESTÁDIO DE	PERIODONTITE	ESTÁDIO I	ESTÁDIO II	ESTÁDIO III	ESTÁDIO IV
SEVERIDADE	Perda de Inserção Clínica Interproximal (PCI) (no sítio com a maior perda)	PCI = 1 - 2mm	PCI = 3 - 4mm	PCI ≥ 5mm	PCI ≥ 5mm
	Perda Óssea Radiográfica	POA < 15%	POA = 15 - 33%	POA = além do terço médio	POA = além do terço médio
	Perda Dental (devido à periodontite)			≤ 4 dentes perdidos	≥ 5 dentes perdidos
COMPLEXIDADE	Local/ Sítio	• PCS ≤ 4 mm • Perda óssea Horizontal	• PCS ≤ 5 mm • Perda óssea Horizontal	• PCS ≥ 6 mm • Perda óssea Vertical ≤ 3 mm	• PCS ≥ 6 mm • Perda óssea Vertical ≤ 3 mm
	Extensão e Distribuição			POA > 3mm. Furca Grau II ou III	Furca Grau II ou III Colapso oclusal Mobilidade Grau > 2
	Localizada < 30%				
	Generalizada ≥ 30%				
	Padrão Inc/Mol				

tti et al., 2018

Profª. Bruna Di Profia

Graus de periodontite

Levam em consideração a evidência ou risco de progressão e antecipam o risco de progressão futura, a possibilidade de insucesso na terapia periodontal e o risco da doença periodontal impactar de maneira negativa a saúde sistêmica do paciente.

A evidência direta é baseada em observações longitudinais (RX).

A evidência indireta é baseada no exame de perda óssea em função da idade no dente mais afetado da dentição.

O grau da periodontite pode ainda ser modificado pela presença de fatores de risco.

	PROGRESSÃO	GRAU A	GRAU B	GRAU C
EVIDÊNCIA DIRETA	PERDA ÓSSEA Rx ou PERDA DE INSERÇÃO	Nenhuma perda em 5 anos	< 2mm em 5 anos	≥ 2mm em 5 anos
EVIDÊNCIA INDIRETA	% PERDA ÓSSEA/IDADE	< 0.25	0.25 - 1.0	> 1.0
	FENÓTIPO DO CASO	↑ biofilme ↓ destruição	biofilme destruição	↓ biofilme ↑ destruição
FATORES DE RISCO	FUMO	Não fumante	< 10 cigarros/dia	≥ 10 cigarros/dia
	DIABETES	Normoglicêmico	HbA1c < 7.0%	HbA1c > 7.0%

	ÍNDICE DE PERDA ÓSSEA	
	MATERIAL	
COMO FAZER?	Radiografia Periapical Régua Milimetrada Idade do paciente	
COMO AVALIAR?	 UEC-1 6 mm Crista Óssea 3 mm Ápice Paciente de 37 anos de idade	Porcentagem de perda óssea % PO = $\frac{6}{9} \times 100 = 66\%$
COMO ANOTAR?	Índice de Perda Óssea %PO/idade do paciente	Índice de Perda Óssea 66/37 = 1,7 (Alto Risco)

Índice de Higiene Oral Simplificado (IHO-S)

Avalia a presença de biofilme e presença de cálculo dental.

IHOS = Índice de placa + índice de cálculo.

Arcos Dentais divididos em sextantes.

Um dente índice em cada sextante.

Materiais:

- Dappen.
- Eviplac.
- Escovas.
- Escova de robson.
- Cotonete.
- Vaselina - dentes com material restaurador.

Dentes com índice:

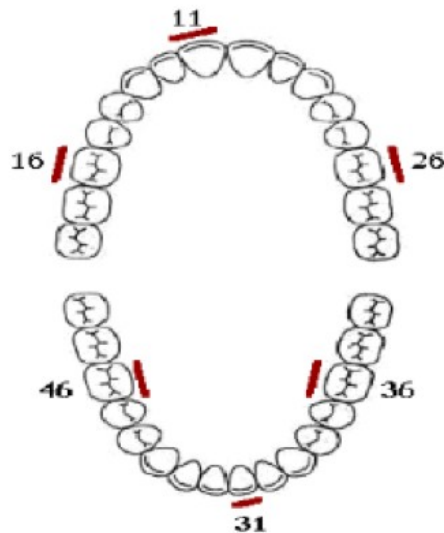
Considerar dentes totalmente erupcionados.

Nos dentes posteriores é avaliado o primeiro dente a distal do segundo pré-molar.

Na ausência de um dos dentes índices, substituir pelo elemento subsequente do mesmo grupo.

Na ausência do 11 e 31, examinar os IC do lado oposto.

Pelo menos 2 das 6 superfícies possíveis precisam ser examinadas.



Face Vestibular: 16 11 26 31

55 51 65 75

Face Lingual: 46 36

85 75

ANOTAÇÕES

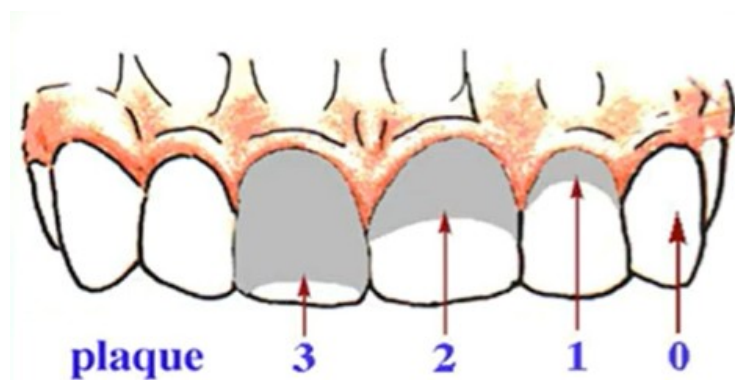
04

ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA

Estudos Epidemiológicos (parte 4)

Critérios para registro do Índice de Placa

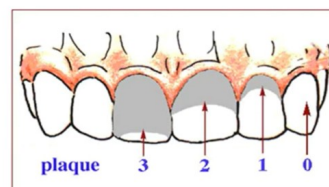
Código	Definição
0	Nenhuma placa observada
1	Pouca placa, menos de 1/3 da superfície dental coberta
2	Placa cobrindo mais de 1/3 e menos de 2/3 da superfície dental
3	Placa cobrindo mais de 2/3 da superfície dental
x	Dente índice e substituto inexistentes



Cálculo de IHOS

Critérios para registro do Índice de Cálculo

Código	Definição
0	Nenhum cálculo observado
1	Pouco cálculo, menos de 1/3 da superfície dental coberta
2	Cálculo cobrindo mais de 1/3 e menos de 2/3 da superfície dental
3	Cálculo cobrindo mais de 2/3 da superfície dental
x	Dente índice e substituto inexistentes

Ativar o Windows
Acesse Configurações pa

Índice de Placa:

$$\frac{\text{Somatório dos escores de cada superfície examinada}}{\text{Número de superfícies examinadas}}$$

Índice de Cálculo:

$$\frac{\text{Somatório dos escores de cada superfície examinada}}{\text{Número de superfícies examinadas}}$$

IHOS: ÍNDICE DE PLACA + ÍNDICE DE CÁLCULO

Apenas placa ou apenas cálculo

Interpretação Clínica	Resultado do cálculo
Higiene oral BOA	0.0 – 0.6
Higiene oral REGULAR	0.7 – 1.8
Higiene oral RUIM	1.9 – 3.0

Placa + Cálculo

Resultado	Interpretação (Pereira)
0 – 1,2	Higiene oral satisfatória
1,3 – 3,0	Higiene oral regular
3,1 – 6,0	Higiene oral deficiente

Índice O'leary

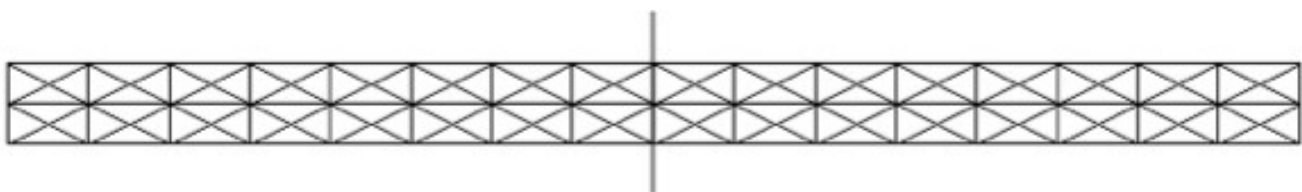
Identificar a porcentagem de placa bacteriana, evidenciada por corantes, nas faces dentais de todos os dentes presentes na arcada.

Serve como motivação ao paciente.

Muito utilizado em pediatria.

Avalia quantidade de biofilme, seu controle e qualidade da higiene;

As faces valorizadas são as faces livres (V, L, D e M). E examinamos de todos os dentes, através da evidencição de biofilme



Em seguida, é só efetuar o cálculo]

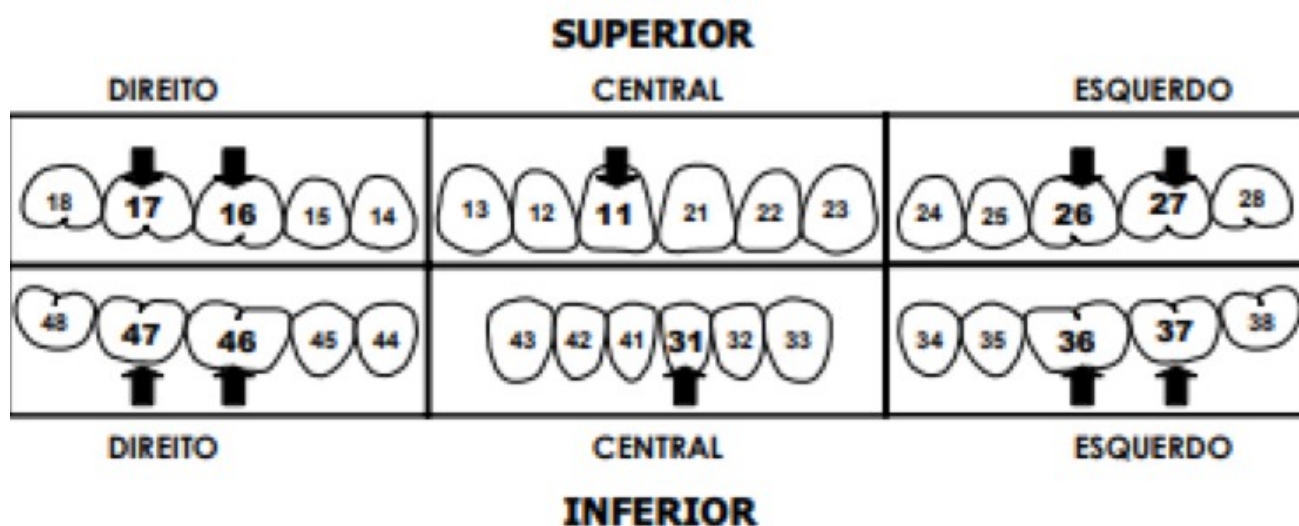
$$\frac{\text{Número de faces coradas} \times 100}{\text{Número total de dentes} \times 4} = \text{IP\%}$$

0 a 25%	Satisfatório
De 25 a 40%	Irregular
De 40 acima	Insatisfatório

Resultados

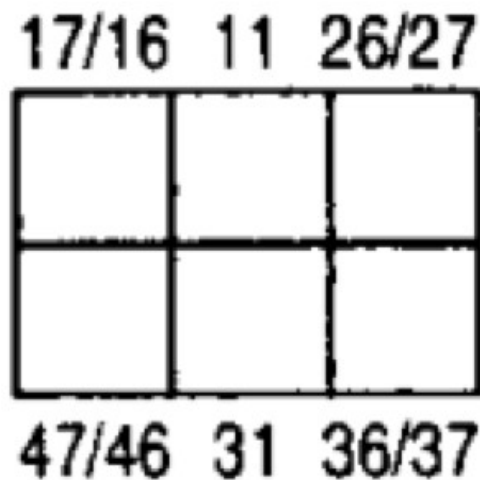
Índice Periodontal Comunitário (IPC)

Avaliar a presença de sangramento gengival, cálculo e bolsa periodontal.



Até 19 anos: 16, 11, 26, 36, 21 e 46. 20 anos ou mais: 17, 16, 11, 26, 27, 37, 36, 31, 46 e 47.

0 — sextante hígido. 1 — sextante com sangramento. 2 — presença de cálculo (qualquer quantidade, mas com toda a área preta da sonda visível). 3 — bolsa de 4mm a 5mm (margem gengival na área preta da sonda). 4 — bolsa de 6mm ou mais (área preta da sonda não está visível). X — sextante excluído (menos de 2 dentes presentes). 9 — sextante não examinado.



Registros — Considerar que:

- A) Em crianças com menos de 15 anos não são feitos registros de bolsas! = alterações de tecidos moles podem estar associadas à erupção e não à presença de alteração periodontal patológica;
- B) Embora 10 dentes sejam examinados, apenas 6 anotações são feitas: uma por sextante, relativa à pior situação encontrada;
- C) Quando não há no sextante pelo menos dois dentes remanescentes e não indicados para extração, cancelar o sextante registrando um "X".

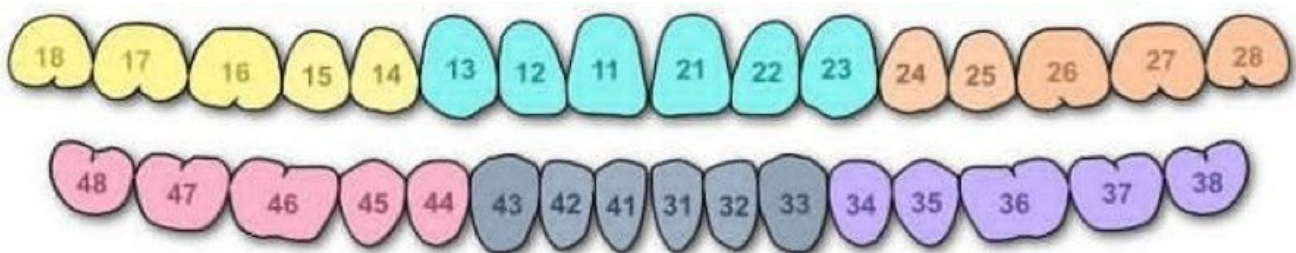
Índice de sangramento gengival (PSR)

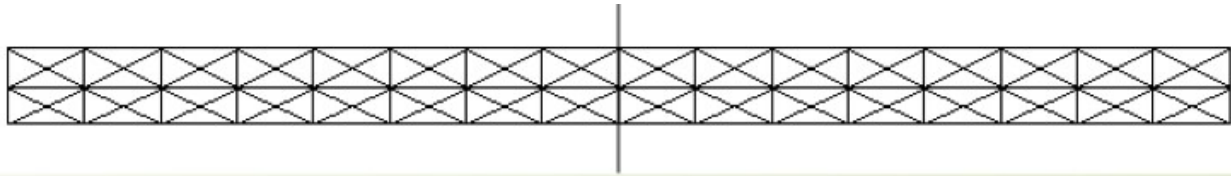
Avalia a presença de sangramento gengival.

Exame das faces livres e proximais com a sonda;

ISG% : maneira semelhante ao Índice de Placa de O'Leary;

As unidades ausentes devem ser totalmente pintadas em azul.





Em seguida, é só efetuar o cálculo:

$$\frac{\text{Número de faces com sangramento} \times 100}{\text{Número total de dentes} \times 4} = \text{ISG\%}$$

CEO-D

PONTOS-CHAVE

Utilizado para dentição decídua.

Letra "e" inclui: Dentes Cariados; Dentes com extração indicada; Dentes obturados.

Os dentes extraídos não são incluídos por ser difícil separar os que foram extraídos por cárie daqueles que passaram pelo processo natural de esfoliação natural.



ANOTAÇÕES

Agravos à Saúde Bucal

Saúde Coletiva em Odontologia

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 6

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Agravos à Saúde Bucal	3
02 Agravos à Saúde Bucal (parte 2)	8
03 Agravos à Saúde Bucal (parte 3)	13
04 Agravos à Saúde Bucal (parte 4)	17

01

SAÚDE COLETIVA EM ODONTOLOGIA

Agravos à Saúde Bucal

Aula ministrada pelo Dr. Prof. Marcos, em 04 de Novembro de 2022, na Universidade Cidade de São Paulo

Edentulismo**PONTOS-CHAVE**

- Perda total ou parcial dos dentes permanentes;
- Consequência de eventos mutilatórios que sucedem durante toda vida;
- Decorre, na maioria das vezes, de uma prática voltada para extrações dentárias subsequentes a agravos bucais.

Motivos que causam o Edentulismo:

- Edentulismo por impacto ou trauma;
- Edentulismo pelo uso de medicamentos (osteoporose - supressores do metabolismo ósseo - ; osteonecrose - uso de quimioterápicos e radioterápicos).
- Edentulismo por iatrogenia.
- Edentulismo causado por cárie.
- Edentulismo por consequência da periodontite.

Principais fatores de risco:

- Baixa renda.
- Baixa escolaridade.
- Fator congênito.
- Susceptibilidade a cárie dentária.
- Susceptibilidade a doença periodontal.
- Falta de acesso a tratamentos odontológicos básicos e especializados.

Tipos de próteses

- Critérios e códigos são definidos de acordo com o tipo de prótese utilizada, fixas ou removíveis E totais e parciais. Removíveis parciais (PPR com grampos). Removível total (prótese total removível). Fixas unitárias. Fixas parciais (ponte fixa ou prótese parcial fixa). Fixas totais (prótese sobre implante).

Dimensões	Códigos	Critérios
Uso de prótese	0	Não usa prótese dentária.
	1	Usa uma ou mais pontes fixas.
	2	Usa prótese parcial removível.
	3	Usa uma ponte fixa e prótese parcial removível.
	4	Usa prótese dentária total removível.
	5	Usa prótese dentária total fixa (sobredentadura/sobreimplante/overdenture).
	9	Sem informação.

Necessidade de prótese	0	Não necessita de prótese dentária.
	1	Necessita de uma prótese, fixa ou removível, para substituição de um elemento.
	2	Necessita de uma prótese, fixa ou removível, para substituição de mais de um elemento.
	3	Necessita de uma combinação de próteses, fixas e/ou removíveis, para substituição de um e/ou mais elemento(s).
	4	Necessita de prótese dentária total.
	9	Sem informação.

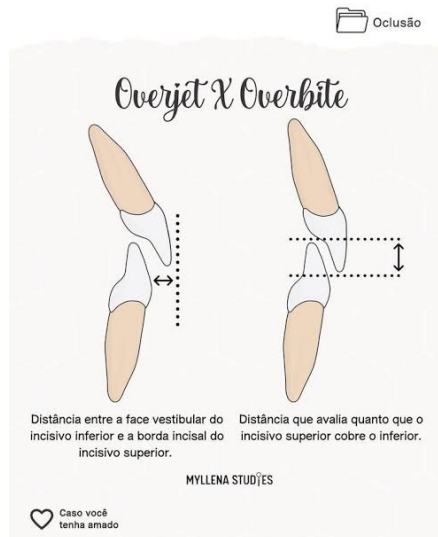
Código e critérios para a avaliação do uso e necessidade de prótese dentária superior e inferior

Condição da oclusão dentária

Conceitos

Overjet (sobressalência): distância horizontal entre os dentes da arcada superior e os da arcada inferior (1 a 2mm).

Overbite (sobremordida): distância vertical entre os dentes da arcada superior e os da arcada inferior (2 a 3mm).



Mal oclusão - conjunto de anomalias dentofaciais que causam deformação ou impedem a função e que, portanto, requerem tratamento.

A mal oclusão é a 3ª maior prevalência entre as patologias bucais.

O termo mal oclusão pode ser **definido** como desvio da oclusão ideal, ou seja, inclui todos os desvios dos dentes e maxilares do alinhamento normal.

Diagnóstico e intervenção precoces - fundamental o conhecimento do desenvolvimento normal das dentições decídua e mista.

Evitar tratamentos mais complexos, devido a um pior prognóstico no futuro.

Instalação e a permanência de alterações dento-esqueléticas apresentam vários efeitos na estética e nas funções orofaciais.

Interferem negativamente na qualidade de vida.

Prejuízos na interação social;

Bem-estar psicológico dos indivíduos acometidos.



Classe I: a cúspide méso-vestibular (MV) do primeiro molar superior oclui o sulco vestibular do primeiro molar permanente.

Classe II ou distocclusão: relação "distal" da mandíbula em relação à maxila. A cúspide MV do primeiro molar superior permanente oclui anteriormente ao sulco vestibular do primeiro molar inferior permanente.

Classe III, primeira divisão: os incisivos superiores encontram-se projetados vestibularmente. Comum haver sobremordida acentuada e overjet acentuado. Função muscular anormal.

Classe III, segunda divisão: incisivos centrais superiores encontram-se verticalizados ou lingualizados e os incisivos laterais vestibularizados. É comum observarmos uma sobremordida bastante exagerada.

Classe III ou mesioclusão: A cúspide MV do 1° MS permanente oclui posteriormente ao sulco vestibular do 1° MI permanente. Relação “mesial” da mandíbula em relação à maxila.

Dentro de cada grupo de maloclusão, podem ser encontrados vários problemas, os quais podem aparecer isolados ou concomitantes:

- Mordida cruzada;
- Mordida aberta;
- Sobressaliência aumentada;
- Sobremordida profunda;
- Apinhamento dental;
- Presença de hábitos bucais deletérios;
- Perdas precoces dentais;

Índice de avaliação da condição da oclusão dentária na dentição permanente

2 dimensões:

1. Espaço; 2. Oclusão;

Critérios: número de incisivos, caninos e PM ausentes nas arcadas superiores e inferiores.

Espaço

Apinhamento no segmento incisal

Definido de canino a canino;



Considera-se apinhamento quando há dentes com giroversão ou mal posicionados no arco;

Não se considera apinhamento quando os incisivos estão adequadamente alinhados e um ou ambos caninos estão deslocados.

- 0: sem apinhamento;
- 1: apinhamento em um segmento;

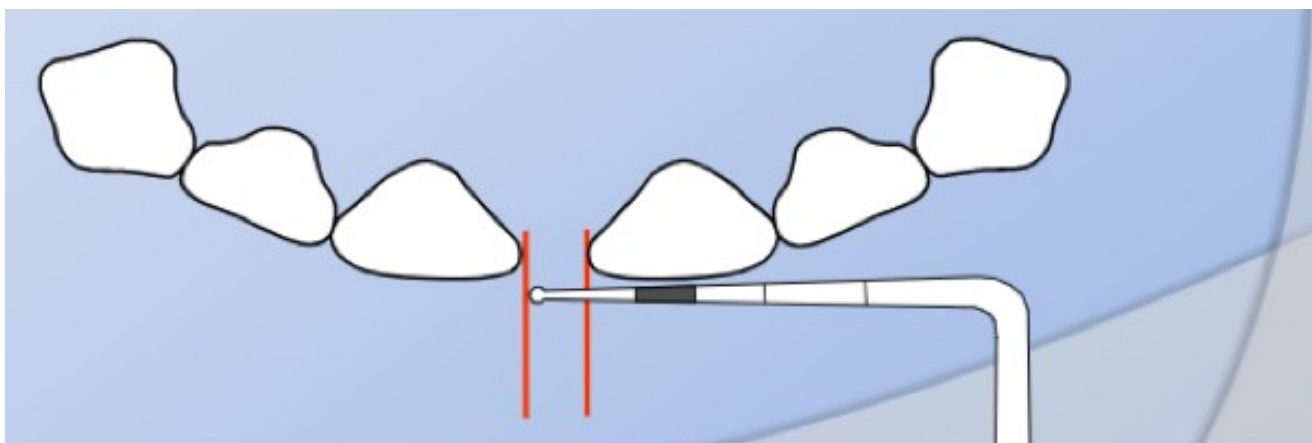
2: apinhamento em dois segmentos;

Espaçamento no segmento incisal



Examina ambos os arcos; Distância intercaninos é suficiente para o adequado posicionamento de todos os incisivos e ainda sobra espaço e/ou um ou mais incisivos tem uma ou mais superfícies proximais sem contato interdental.

Diastema incisal



Espaço, em milímetros, entre os dois incisivos centrais superiores permanentes, quando estes perdem o ponto de contato.

Valor registrado: mm com a sonda OMS;

Ausência de IC: Código "X".

ANOTAÇÕES

02

SAÚDE COLETIVA EM ODONTOLOGIA

Agravos à Saúde Bucal (parte 2)

Desalinhamento anterior maxilar

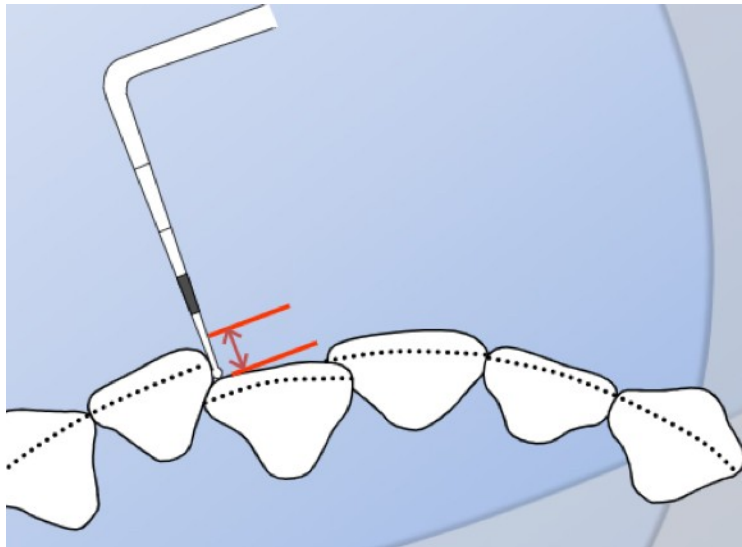
Podem ser giroversões ou deslocamentos em relação ao alinhamento normal.

Os 4 incisivos superiores são examinados registrando-se a MAIOR IRREGULARIDADE entre os dentes adjacentes.

O desalinhamento pode ocorrer com ou sem apinhamento.

Desalinhamento anterior mandibular

O conceito e procedimentos são semelhantes ao arco superior.

**Oclusão****Overjet Maxilar Anterior**

Distância, em mm, entre as superfícies vestibulares do incisivo superior mais proeminente e do incisivo inferior correspondente;

Não é medida na ausência de incisivos superiores ou se possuem mordida cruzada lingual;

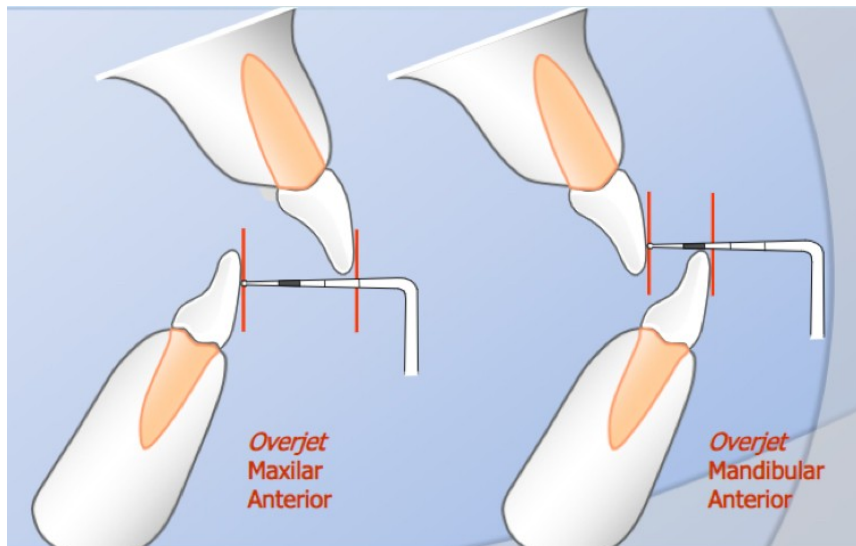
Quando a mordida é do tipo “topo-a-topo” o valor é 0.

Overjet Maxilar Anterior (protusão ou mordida cruzada)

Quando algum incisivo inferior se posiciona anteriormente ou por vestibular em relação ao seu correspondente superior;

Medida em mm (Sonda OMS);

Não considerar : Situações em que há giroversão de incisivo inferior, com apenas uma parte do bordo incisal em seu cruzamento;



Mordida aberta vertical anterior

Se há falta de ultrapassagem vertical entre incisivos opostos;

O tamanho da distância entre os bordos incisais é medido com sonda OMS e o valor registrado em mm.



Relação molar ântero-posterior

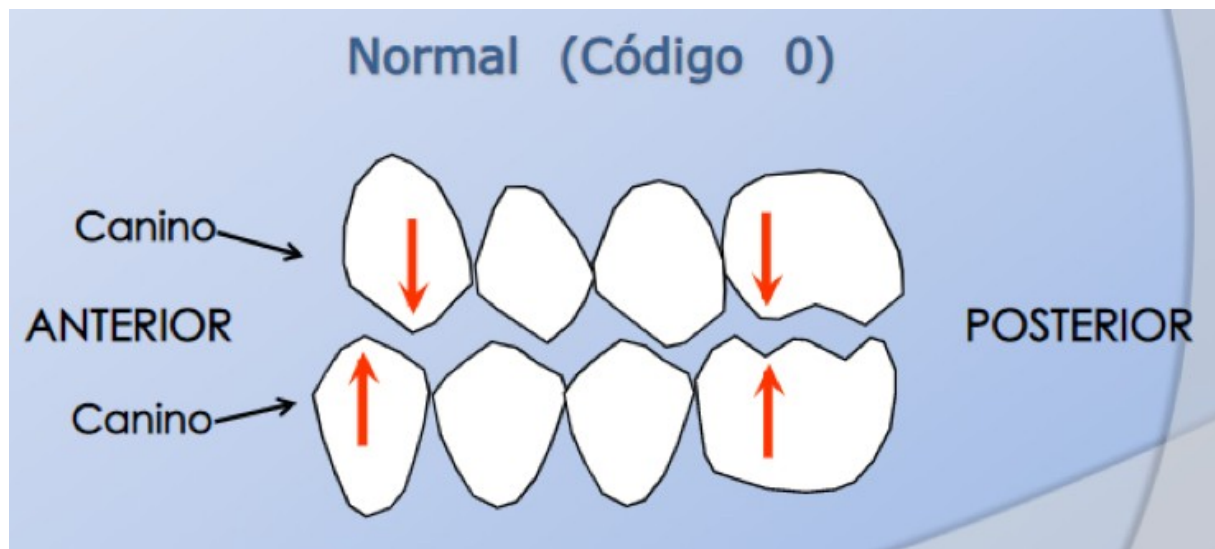
Avaliação feita com base na relação entre os primeiros molares permanentes, superior e inferior.

Se isso não é possível por que um ou ambos estão ausentes, não completamente erupcionados, ou alterados em virtude de cárie ou restaurações, então os caninos e pré-molares são utilizados.

Os lados direito e esquerdo são avaliados com os dentes em oclusão e apenas o maior desvio da relação molar normal é registrado.

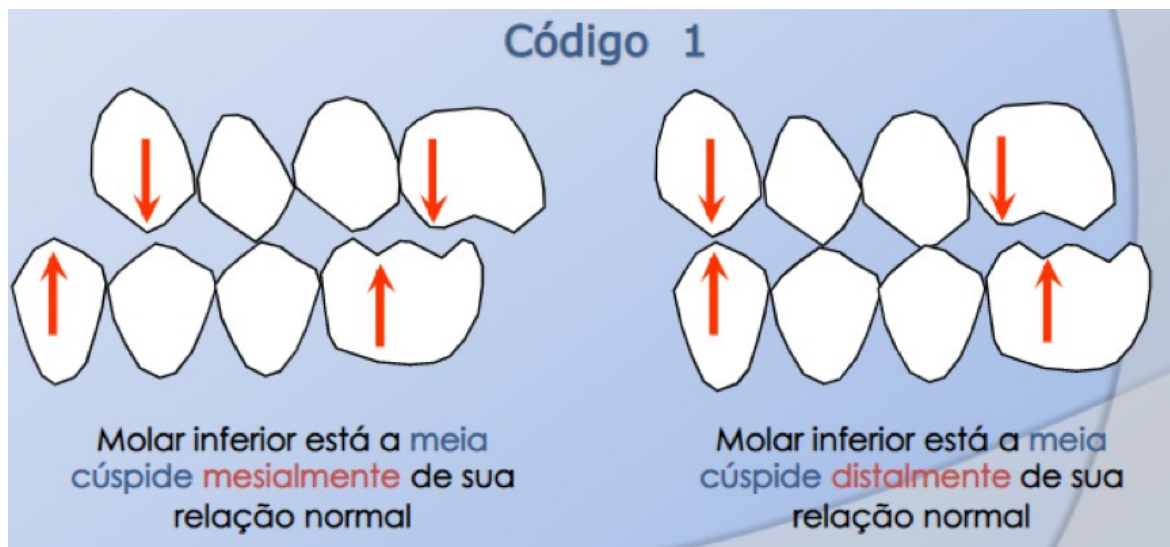
PONTOS-CHAVE

0: normal;

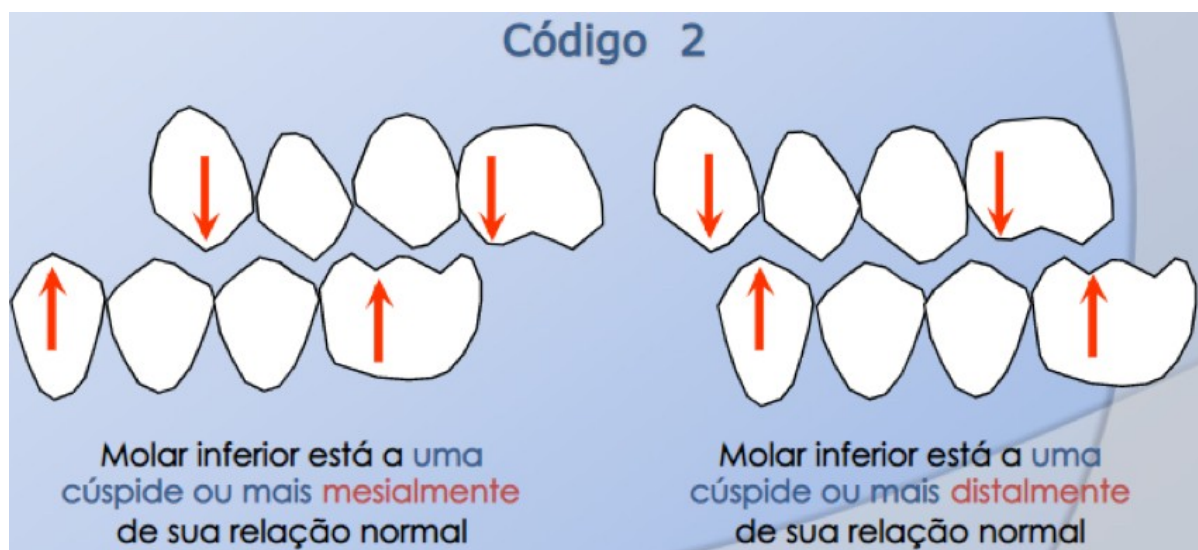


Cúspide méso-vestibular do primeiro molar superior oclui no sulco vestibular do primeiro molar inferior.

1: meia cúspide;



2: cúspide inteira.



Índice de avaliação da condição da oclusão dentária na dentição decídua

Considerar dimensões:

- Chave de caninos;
- Sobressaliência (Overjet);
- Sobremordida (overbite);

Chave de Caninos: 0

CLASSE I

Canino
ANTERIOR
Canino
POSTERIOR

- Cúspide do canino superior no mesmo plano vertical que a superfície distal do canino inferior quando em oclusão cêntrica.
- Marcar classe I caso: cúspide do canino superior estiver da face distal do inferior até a primeira cúspide do primeiro molar inferior

Chave de Caninos: 1

CLASSE II

- Cúspide do canino superior numa relação anterior à superfície distal do canino inferior quando em oclusão cêntrica.
- Marcar classe II caso: cúspide do canino superior estiver topo a topo ou em relação mais mesial com o canino inferior

Chave de Caninos: 2

CLASSE III

- Cúspide do canino superior numa relação posterior à superfície distal do canino inferior quando em oclusão cêntrica.
- Marcar classe III caso: cúspide do canino superior estiver topo a topo com a cúspide do primeiro molar inferior ou em relação mais posterior.

Chave de Caninos: 9

Sem Informação

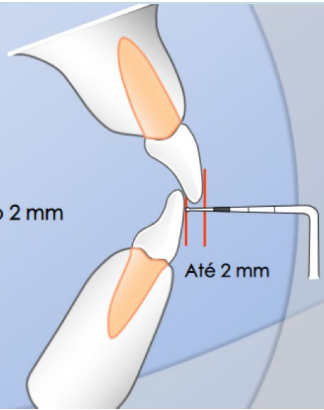
- Quando não for possível realizar o exame ou para o caso de exame em outras faixas etárias

- Mordida cruzada posterior;

Sobressaliência**0 – Normal**

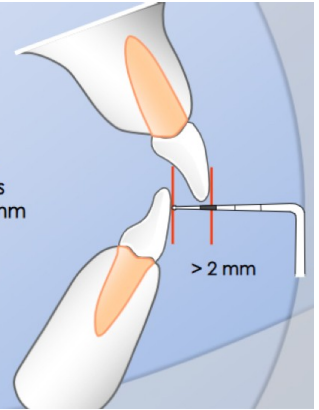
- Existe sobressaliência dos incisivos centrais decíduos superiores não excedendo 2 mm

Até 2 mm

**Sobressaliência****1 – Aumentada**

- Existe sobressaliência dos incisivos centrais decíduos superiores excedendo 2 mm

> 2 mm

**Sobressaliência****2 – Topo a topo**

- Incisivos centrais decíduos superiores e inferiores com as bordas incisais em topo

**Sobressaliência****3 – Cruzada Anterior**

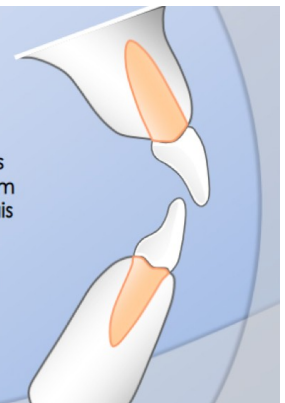
- Incisivos centrais decíduos inferiores ocluindo em relação anterior aos incisivos centrais decíduos superiores.

**Sobremordida****0 – Normal**

- Superfícies incisais dos incisivos centrais inferiores decíduos com contato nas superfícies palatais dos incisivos centrais superiores decíduos quando em oclusão cêntrica

**Sobremordida****1 – Reduzida**

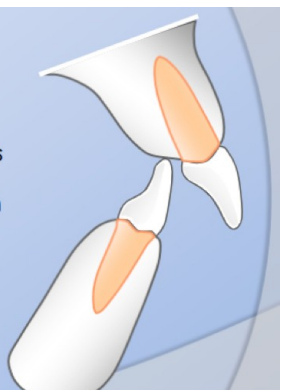
- Superfícies incisais dos incisivos centrais inferiores decíduos sem contato nas superfícies palatais dos incisivos centrais superiores decíduos quando em oclusão cêntrica

**Sobremordida****2 – Aberta**

- Superfícies incisais dos incisivos centrais inferiores decíduos apresentam-se abaixo do nível das superfícies incisais dos incisivos centrais superiores decíduos quando em oclusão cêntrica

**Sobremordida****3 – Profunda**

- Superfícies incisais dos incisivos centrais inferiores decíduos tocando o palato quando em oclusão cêntrica



ANOTAÇÕES

03

SAÚDE COLETIVA EM ODONTOLOGIA

Agravos à Saúde Bucal (parte 3)

Mordida cruzada posterior

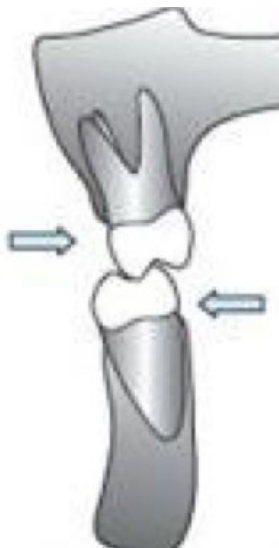
Ausente

0: Molares decíduos superiores ocluindo em uma relação mais vestibular com os molares decíduos inferiores quando em oclusão cêntrica.



Presente

0: Molares decíduos superiores ocluindo em uma relação mais lingual com os molares decíduos inferiores quando em oclusão cêntrica.



Principais fatores de risco

A má oclusão é a deformidade dentofacial que, na maioria das ocasiões, não provém de um único processo patológico específico.

Hereditariedade

PONTOS-CHAVE

Displasia cleidocraniana.

Fissuras palatinas Defeitos de desenvolvimento de origem desconhecida (Amelogênese imperfeita). Hábitos nocivos.

O lábio superior fica curto;
Dentes superiores- Vestibularização;
Palato cresce em profundidade e não lateralmente;
Falta de espaço para o alinhamento dentário.

Enfermidades sistêmicas; Enfermidades locais (obstrução nasal, tumores, doença periodontal, perdas ósseas e migrações, e cárie dentária); Agentes físicos (exodontia prematura de dentes decíduos); Deficiências nutricionais e má nutrição. Fatores culturais e socioeconômicos que dificultem ou impeçam o acesso aos serviços de saúde bucal preventivo-promocionais.

Introdução ao trauma dentoalveolar

Lesões aos dentes e ao processo alveolar são comuns e devem ser consideradas situações de urgência, pois o resultado depende do pronto atendimento à lesão.

Como o tratamento adequado só pode ser realizado após o diagnóstico correto, o processo de diagnóstico deve ser realizado imediatamente.

No caso de traumas mais extensos (fraturas de mandíbula e demais ossos da face, grandes lacerações ou danos às estruturas neurológicas), o paciente deverá ser encaminhado com urgência a um serviço de referência hospitalar.

Quanto às lesões dentoalveolares, podemos observar a ocorrência das mesmas, com maior frequência, na infância e em adultos jovens.

As lesões de luxação são mais comuns na dentição decídua, enquanto as fraturas da coroa são mais comumente relatadas para a dentição permanente.

Trinca.
Fratura de esmalte.
Fratura de esmalte e dentina sem ou com exposição pulpar.
Fratura corono-radicular sem ou com exposição pulpar.
Fratura radicular.

Achados clínicos e radiográficos**Observação de 4 fatores:**

1. Sensibilidade a percussão. 2. Teste de sensibilidade. 3. Mobilidade. 4. Características radiográficas.

Percussão vertical e horizontal

Propicia avaliação clínica da condição inflamatória da região periapical;

Localização do dente responsável pela crise álgica difusa;

Leve pressão ou mesmo percussão sobre a face incisal/oclusal e vestibular dentária com auxílio do cabo do espelho.

Quando o dente encontra-se bastante sensível, uma simples pressão com o dedo já será suficiente para provocar a dor.

A percussão jamais deve ser feita primeiro no dente suspeito, mas antes nos dentes vizinhos, avaliando a sensibilidade durante a percussão de cada dente.

Intensidade da dor: + suave, ++ moderada e +++ severa

Mobilidade

Feita com a utilização de um instrumento rígido (cabo do espelho) em uma face do dente e a ponta do dedo na face oposta.

Toda mobilidade acima de 1 mm deve ser considerada anormal.

Mobilidade grau 1	Mobilidade dental no sentido horizontal de 1 a 2mm;
Mobilidade grau 2	Mobilidade dental no sentido horizontal > 2mm;
Mobilidade grau 3	Mobilidade dental no sentido horizontal e vertical.

Condições pulpares (testes de sensibilidade)

Os testes térmicos com o frio e o calor são recursos auxiliares do diagnóstico;

Tendo como propósito avaliar a sensibilidade pulpar e pressupor sua vitalidade;

Só será confirmada, e se ocorrer, durante a cirurgia de acesso e análise do sangramento presente e da textura e consistência do tecido pulpar.

TESTES TÉRMICOS COM FRIO: tubetes anestésicos preenchidos com água, acondicionados em coletor universal e armazenados no congelador. Lápis de gelo envolto por gaze e pronto para uso. Ver a intensidade da dor.

GÁS REFRIGERANTE: endo-frost Roeko (-50 graus C).

TESTE TÉRMICO COM O CALOR: Guta-percha aquecida; Dentes com comprometimento pulpar crônico podemos ter como resultado falso-

positivo; Orientar o paciente para elevar a mão quando o dente for sensibilizado e, abaixar quando o estímulo cessar, observando o declínio, rápido ou lento e sua ligação com o comprometimento pulpar, semelhante ao teste com o gás refrigerante.

Fraturas dentárias em dentes permanentes

Fraturas de esmalte

Sensibilidade à percussão: negativa;

Teste de sensibilidade: positiva;

Mobilidade: negativa;

Característica radiográfica: sem anormalidades radiográficas.

Fratura de esmalte e dentina sem exposição pulpar

Sensibilidade à percussão: negativa;

Teste de sensibilidade: positiva;

Mobilidade: negativa;

Característica radiográfica: perda visível de esmalte e dentina;

Fratura de esmalte e dentina com exposição pulpar

Sensibilidade à percussão: negativa;

Polpa exposta;

Mobilidade: negativa;

Característica radiográfica: perda visível de esmalte e dentina;

Fratura coronaradicular sem exposição pulpar

Sensibilidade à percussão: positiva; Teste positivo no fragmento apical; Mobilidade: no fragmento coronário;

Característica radiográfica: Extensão apical da fratura geralmente não visível.

Fratura coronaradicular com exposição pulpar

Sensibilidade à percussão: positiva; Polpa exposta; Mobilidade: no fragmento coronário; Característica radiográfica:

Extensão apical da fratura geralmente não visível.

Fratura radicular

Pode estar sensível; Percussão: negativo em primeiro momento; Sangramento excessivo via sulco gengival pode ser observado; Característica radiográfica: envolve a porção radicular e pode estar em um plano horizontal ou oblíquo; A fratura radicular horizontal poderá ocorrer no terço cervical, médio ou apical da raiz.

ANOTAÇÕES

04

SAÚDE COLETIVA EM ODONTOLOGIA

Agravos à Saúde Bucal (parte 4)**Faturas nos tecidos de suporte dos dentes permanentes**

Além de atingir estruturas dentárias, o trauma também poderá causar dano às estruturas de suporte.

Podendo ou não estar associado às fraturas dentárias, o trauma aos tecidos de suporte requer atenção especial, visto que o grau e o manejo da fratura poderão resultar em um prognóstico desfavorável para a manutenção do dente.

Concussão, subluxação, luxação lateral, intrusiva e extrusiva e fratura do processo alveolar.

Concussão

Traumatismo de pequena intensidade sobre os tecidos de sustentação dentária, sem alterar a posição ou provocar mobilidade dentária.

Não apresenta deslocamento ou aumento de mobilidade, ocorrendo apenas sensibilidade à percussão ou oclusão.

Aspectos Radiográficos: Não são observadas alterações.

Subluxação

Traumatismo de intensidade moderada, que determina mobilidade dentária sem mudança de posição;

Sensibilidade a percussão: positiva;

Sangramento via gengival excessivo;

Teste pulpar: positivo;

Radiograficamente: sem alterações.

Luxação lateral

Deslocamento do dente no sentido palatino, vestibular, mesial ou distal. Nova posição na arcada; Sangramento e laceração dos tecidos periodontais adjacentes. Deslocamento do dente dentro do alvéolo; Ligamento Periodontal aumentado + fratura do processo alveolar. Sensibilidade pulpar: negativo. Radiograficamente: deslocamento dental.

Luxação extrusiva

Deslocamento parcial do dente fora do seu alvéolo. Presença de grande hemorragia. Mobilidade excessiva; Desnível entre os bordos incisais; Radiograficamente: aumento do espaço periodontal.

Lesão intrusiva

Deslocamento do dente para o interior do seu alvéolo, em direção axial; O dente pode estar em infra oclusão ou totalmente desaparecido. Possível presença de abaulamento da tábua óssea vestibular. Edema em tecidos moles. Graus variados de mobilidade.

Teste de percussão: som metálico.

Radiograficamente : deslocamento apical e descontinuidade do ligamento periodontal;

Sensibilidade pulpar: negativo.

Fratura do processo alveolar

Deslocamento de osso alveolar e de um dente ou mais ao mesmo tempo;

Linhas de fratura podem ser localizadas em qualquer nível, desde o osso marginal até o ápice radicular.

Sensibilidade pulpar: pode gerar falso positivo/negativo.

Avulsão na dentição permanente

Deslocamento do dente para fora do seu alvéolo.

Considerar a possibilidade de intrusão total (RX OBRIGATÓRIO!).

Como reagir frente a um caso de avulsão?

1. O paciente ou responsável deve encontrar o dente e segurá-lo pela coroa, evitando tocar na porção radicular;
2. Se o dente estiver sujo, o paciente ou responsável deve lavá-lo rapidamente por, no máximo, 10 segundos, em água corrente fria e reposicioná-lo no alvéolo.
3. Tente encorajar o paciente ou o responsável a reimplantar o dente. Uma vez que o dente foi reimplantado, solicite que o paciente morda um lenço para mantê-lo em posição.

PONTOS-CHAVE

Se não der certo: oriente a colocação do dente meus meio de armazenamento adequado.

Meios de armazenamento

1. Solução salina balanceada de hank (HBSS).

HBSS = composto não tóxico de células com nutrientes essenciais que tem um pH de 7,2;
Capacidade de preservar e reconstituir as células do ligamento periodontal de dentes mantidos fora do alvéolo (24 horas);
Teve comprovada eficácia de manter a viabilidade das células do ligamento periodontal;

2. Própolis.

3. Água de coco.

Potássio, cálcio, e magnésio;
Biologicamente puro.
Manutenção de viabilidade das células do ligamento periodontal devido aos nutrientes presentes (proteínas, aminoácidos, vitaminas e minerais).

4. Leite.

O leite apresenta uma osmolalidade e um pH adequados, além de substâncias nutricionais para manter a viabilidade das células do ligamento periodontal.
Pasteurização: redução das bactérias, diminuindo a contaminação do dente.
Apenas previne a morte celular, e não restaura a morfologia normal nem a habilidade de diferenciação e mitose.

5. Saliva.

Meio prontamente disponível: não devem ser armazenados por mais de 30 minutos.
Contém substâncias potencialmente prejudiciais, tais como enzimas, bactérias e seus subprodutos.
Não preservação do ligamento periodontal;

6. Água de torneira.

Meio hipotônico: causa a lise celular, não sendo um meio de armazenamento compatível com as células do ligamento periodontal.
pH : 7,4 a 7,8.
Pode ser tão destrutivo para o ligamento periodontal, quanto deixar o dente seco;

Anquilose e reabsorção por substituição.

Incidência

Sexo Masculino > Sexo Feminino

Dentes Superiores > Dentes Inferiores

Dentes Anteriores > Dentes Posteriores

Incisivos Centrais > Incisivos Laterais > Caninos

Traumatismos dentários

O traumatismo dentário representa um problema de saúde pública;

Alta prevalência em crianças e adolescentes;

Impacto psicossocial e na qualidade de vida;

Identificação da necessidade de programas de prevenção e controle, já que suas causas são amplamente conhecidas e os custos de tratamento são elevados.

Diferentes índices têm sido utilizados para estabelecer a prevalência, a extensão e a gravidade das lesões traumáticas na dentição permanente.

Entretanto, os índices apresentam em comum os critérios para a identificação de fraturas coronárias e a ausência do dente devido a traumatismo.

Índice de O'Brien

Avaliação do traumatismo dentário em incisivos superiores e inferiores permanentes;

Adota critérios que indicam sinais clínicos da extensão da fratura coronária e avulsão dentária.

Código	Condições	Critérios
1	Fratura tratada	Há um histórico de fratura e foi realizada a restauração do dente.
2	Fratura em esmalte	Perda de pequena porção da coroa envolvendo apenas esmalte, ou fratura envolvendo esmalte.
3	Fratura em esmalte e dentina	Perde de porção maior da coroa, envolvendo esmalte e dentina
4	Fratura com envolvimento pulpar	Perda de porção maior da coroa, envolvendo esmalte e dentina com envolvimento pulpar.
5	Perda do dente por trauma	Deslocamento completo do dente para fora do seu alvéolo, ou seja, saída total do dente para fora do osso alveolar
6	Outros danos	Luxação lateral, intrusiva, extrusiva, fratura radicular e do processo alveolar
9	Dente excluído	O dente não pode ser examinado

O dente é excluído devido a: restos radiculares; dente perdido por cárie; presença de agenesia; aparelho ortodôntico.

ANOTAÇÕES